ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

Libro Gordo

INFECTOLOGÍA

90 preguntas de práctica

Microbiología Clínica

MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Infectología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
BLOQUE 1: URGENCIAS CRÍTICAS, SEPSIS E INFECCIONES DEL SNC					
1.04.2.001	Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q10, Q11, Q12	Tomo 02 · 1.3 (Pág. 9)
1.04.2.002	Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q11, Q12, Q13	Tomo 02 · 1.3 (Pág. 9)
1.04.2.003	Endocarditis bateriana	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q1, Q2, Q3	Tomo 01 · 4.7 (Pág. 80)
1.04.2.004	Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q14, Q15, Q16	Tomo 02 · 1.4 (Pág. 11)
1.04.2.005	Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q15, Q16, Q17, Q18	Tomo 02 · 1.4 (Pág. 11)
1.04.2.006	Meningitis Aguda Bacteriana y Viral	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q6, Q7, Q8, Q9	Tomo 02 · 1.2 (Pág. 7)
1.04.2.007	Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q4, Q5	Tomo 02 · 1.1 (Pág. 5)
BLOQUE 2: SALUD PÚBLICA, PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN E IAAS					
1.04.1.007	Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q33, Q34, Q35	Tomo 02 · 2.4 (Pág. 22)
1.04.1.009	Diarrea asociada a antibióticos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q19, Q20, Q21, Q22	Tomo 06 · 3.1 (Pág. 37)
1.04.1.015	IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q30, Q31, Q32	Tomo 02 · 2.3 (Pág. 20)
1.04.1.026	Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q34, Q35, Q36	Tomo 02 · 2.4 (Pág. 22)
1.04.1.029	Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q23	Tomo 02 · 5.6 (Pág. 65)
1.04.2.009	Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q27, Q28, Q29	Tomo 02 · 2.2 (Pág. 18)
1.04.2.011	Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q24	Tomo 02 · Infectología (Pág. 8)
1.04.3.001	Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q25, Q26	Tomo 02 · 2.1 (Pág. 16)
1.04.3.002	Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q28, Q29	Tomo 02 · 2.2 (Pág. 18)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.04.3.005	IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q31, Q32	Tomo 02 · 2.3 (Pág. 20)
1.04.3.008	Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q28, Q29	Tomo 02 · 2.2 (Pág. 18)
1.04.3.009	Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q25, Q26	Tomo 02 · 2.1 (Pág. 16)
1.04.3.010	Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q25, Q26	Tomo 02 · 2.1 (Pág. 16)
1.04.3.012	Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q28, Q29	Tomo 02 · 2.2 (Pág. 18)
BLOQUE 3: INFECCIONES CRÓNICAS, RETROVIRALES Y GRANULOMATOSAS					
1.04.1.005	Candidiasis oral y esofágica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q37	Tomo 06 · 3.2 (Pág. 39)
1.04.1.010	Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q50, Q51, Q52, Q53, Q54	Tomo 02 · 3.5 (Pág. 35)
1.04.1.014	Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES)	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q38, Q39, Q40	Tomo 02 · 3.1 (Pág. 27)
1.04.1.019	Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q41, Q42, Q43	Tomo 02 · 3.2 (Pág. 29)
1.04.1.023	Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q47, Q48, Q49	Tomo 02 · 3.4 (Pág. 33)
1.04.1.028	Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q44, Q45, Q46	Tomo 02 · 3.3 (Pág. 31)
1.04.3.006	Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q42, Q43	Tomo 02 · 3.2 (Pág. 29)
1.04.3.009	Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q45, Q46	Tomo 02 · 2.1 (Pág. 16)
BLOQUE 4: ZOONOSIS, MEDICINA TROPICAL Y VECTORES					
1.04.1.003	Ántrax (Carbunco Cutáneo y Respiratorio)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q72	Tomo 02 · 4.6 (Pág. 50)
1.04.1.004	Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q69	Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48)
1.04.1.008	Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q61, Q62, Q63	Tomo 02 · 4.3 (Pág. 44)
1.04.1.012	Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q70	Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48)
1.04.1.013	Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q65, Q66, Q67	Tomo 02 · 4.4 (Pág. 46)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.04.1.017	Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q71	Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48)
1.04.1.018	Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q62, Q63, Q64	Tomo 02 · 4.3 (Pág. 44)
1.04.1.022	Parasitosis intestinales	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q55	Tomo 06 · 5.5 (Pág. 79)
1.04.1.027	Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q66, Q67, Q68	Tomo 02 · 4.4 (Pág. 46)
1.04.2.008	Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SCPH)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q56, Q57, Q58	Tomo 02 · 4.1 (Pág. 40)
1.04.4.016	Enfermedad de Chagas: Aguda, Indeterminada y Crónica	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q59, Q60	Tomo 02 · 4.2 (Pág. 42)
BLOQUE 5: INFECCIONES COMUNITARIAS, EXANTEMAS Y HUÉSPED INMUNOCOMPROMETIDO					
1.04.1.001	Adenitis, adenoflegmón	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q73	Tomo 06 · 1.1 (Pág. 5)
1.04.1.006	Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q76, Q77, Q78	Tomo 02 · 5.1 (Pág. 55)
1.04.1.011	Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q82, Q83, Q84, Q85, Q86	Tomo 02 · 5.3 (Pág. 59)
1.04.1.016	Influenza	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q74	Tomo 02 · 5.6 (Pág. 65)
1.04.1.020	Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q88, Q89	Tomo 02 · 5.5 (Pág. 63)
1.04.1.021	Osteomielitis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q75	Tomo 06 · 5.4 (Pág. 77)
1.04.1.024	Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q89, Q90	Tomo 02 · 5.5 (Pág. 63)
1.04.1.025	Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q79, Q80, Q81	Tomo 02 · 5.2 (Pág. 57)
1.04.2.010	Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q85, Q86, Q87	Tomo 02 · 5.4 (Pág. 61)

ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Infectología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

TOMO 02 · PARTE B: ORDEN NUMÉRICO

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.04.1.001	Adenitis, adenoflegmón	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q73	Tomo 06 · 1.1 (Pág. 5)
1.04.1.003	Ántrax (Carbunco Cutáneo y Respiratorio)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q72	Tomo 02 · 4.6 (Pág. 50)
1.04.1.004	Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q69	Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48)
1.04.1.005	Candidiasis oral y esofágica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q37	Tomo 06 · 3.2 (Pág. 39)
1.04.1.006	Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q76, Q77, Q78	Tomo 02 · 5.1 (Pág. 55)
1.04.1.007	Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q33, Q34, Q35	Tomo 02 · 2.4 (Pág. 22)
1.04.1.008	Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q61, Q62, Q63	Tomo 02 · 4.3 (Pág. 44)
1.04.1.009	Diarrea asociada a antibióticos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q19, Q20, Q21, Q22	Tomo 06 · 3.1 (Pág. 37)
1.04.1.010	Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q50, Q51, Q52, Q53, Q54	Tomo 02 · 3.5 (Pág. 35)
1.04.1.011	Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q82, Q83, Q84, Q85, Q86	Tomo 02 · 5.3 (Pág. 59)
1.04.1.012	Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q70	Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48)
1.04.1.013	Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q65, Q66, Q67	Tomo 02 · 4.4 (Pág. 46)
1.04.1.014	Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES)	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q38, Q39, Q40	Tomo 02 · 3.1 (Pág. 27)
1.04.1.015	IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q30, Q31, Q32	Tomo 02 · 2.3 (Pág. 20)
1.04.1.016	Influenza	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q74	Tomo 02 · 5.6 (Pág. 65)
1.04.1.017	Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q71	Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48)
1.04.1.018	Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q62, Q63, Q64	Tomo 02 · 4.3 (Pág. 44)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.04.1.019	Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q41, Q42, Q43	Tomo 02 · 3.2 (Pág. 29)
1.04.1.020	Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q88, Q89	Tomo 02 · 5.5 (Pág. 63)
1.04.1.021	Osteomielitis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q75	Tomo 06 · 5.4 (Pág. 77)
1.04.1.022	Parasitosis intestinales	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q55	Tomo 06 · 5.5 (Pág. 79)
1.04.1.023	Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q47, Q48, Q49	Tomo 02 · 3.4 (Pág. 33)
1.04.1.024	Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q89, Q90	Tomo 02 · 5.5 (Pág. 63)
1.04.1.025	Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q79, Q80, Q81	Tomo 02 · 5.2 (Pág. 57)
1.04.1.026	Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q34, Q35, Q36	Tomo 02 · 2.4 (Pág. 22)
1.04.1.027	Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q66, Q67, Q68	Tomo 02 · 4.4 (Pág. 46)
1.04.1.028	Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q44, Q45, Q46	Tomo 02 · 3.3 (Pág. 31)
1.04.1.029	Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q23	Tomo 02 · 5.6 (Pág. 65)
1.04.2.001	Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q10, Q11, Q12	Tomo 02 · 1.3 (Pág. 9)
1.04.2.002	Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q11, Q12, Q13	Tomo 02 · 1.3 (Pág. 9)
1.04.2.003	Endocarditis bateriana	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q1, Q2, Q3	Tomo 01 · 4.7 (Pág. 80)
1.04.2.004	Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q14, Q15, Q16	Tomo 02 · 1.4 (Pág. 11)
1.04.2.005	Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q15, Q16, Q17, Q18	Tomo 02 · 1.4 (Pág. 11)
1.04.2.006	Meningitis Aguda Bacteriana y Viral	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q6, Q7, Q8, Q9	Tomo 02 · 1.2 (Pág. 7)
1.04.2.007	Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q4, Q5	Tomo 02 · 1.1 (Pág. 5)
1.04.2.008	Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SCPH)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q56, Q57, Q58	Tomo 02 · 4.1 (Pág. 40)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.04.2.009	Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q27, Q28, Q29	Tomo 02 · 2.2 (Pág. 18)
1.04.2.010	Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q85, Q86, Q87	Tomo 02 · 5.4 (Pág. 61)
1.04.2.011	Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q24	Tomo 02 · Infectología (Pág. 8)
1.04.3.001	Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q25, Q26	Tomo 02 · 2.1 (Pág. 16)
1.04.3.002	Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q28, Q29	Tomo 02 · 2.2 (Pág. 18)
1.04.3.005	IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q31, Q32	Tomo 02 · 2.3 (Pág. 20)
1.04.3.006	Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q42, Q43	Tomo 02 · 3.2 (Pág. 29)
1.04.3.008	Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q28, Q29	Tomo 02 · 2.2 (Pág. 18)
1.04.3.009	Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q25, Q26, Q45, Q46	Tomo 02 · 2.1 (Pág. 16)
1.04.3.010	Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q25, Q26	Tomo 02 · 2.1 (Pág. 16)
1.04.3.012	Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q28, Q29	Tomo 02 · 2.2 (Pág. 18)
1.04.4.016	Enfermedad de Chagas: Aguda, Indeterminada y Crónica	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q59, Q60	Tomo 02 · 4.2 (Pág. 42)

SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

BLOQUE 1 URGENCIAS CRÍTICAS, SEPSIS E INFECCIONES DEL SNC

PREGUNTA 1 1.04.2.003

1. **Un paciente de 51 años, con antecedente de un recambio valvular, secundario a una valvulopatía, consulta por un cuadro de 2 semanas de astenia, fiebre y malestar general. Al examen físico tiene T°: 38,2°C, PA: 120/80 mmHg, FC: 94x', se observan lesiones eritematosas en los dedos de ambas manos y algunas petequias en las extremidades inferiores y, en el examen cardíaco, se aprecia un soplo diastólico de intensidad IV/VI. Se solicitan exámenes de sangre, entre los que destaca PCR: 12 mg/L, VHS: 70 mm/h y leucocitosis de 16.000 por mm3. Además, se realizan 3 hemocultivos, que resultan todos positivos para cocáceas Gram positivas, en cadena. ¿Cuál es el antibiótico de elección para iniciar el tratamiento?**

A) Penicilina sódica
B) Cloxacilina
C) Clindamicina
D) Ceftazidima
E) Gentamicina

PREGUNTA 2 1.04.2.003

2. **Paciente operado de válvula cardíaca hace 2 meses. Presenta fiebre, soplo cardíaco nuevo y hemocultivos positivos. ¿Cuál es el agente más probable en endocarditis infecciosa post-cirugía cardíaca precoz?**

A) Staphylococcus aureus o S. epidermidis
B) Streptococcus viridans
C) Enterococcus faecalis
D) HACEK group
E) Candida albicans

PREGUNTA 3 1.04.2.003

3. **Paciente masculino de 45 años, presenta súbitamente hemiparesia derecha, refiere historia de 2 meses de evolución de astenia, compromiso del estado general y fiebre de predominio nocturno. Al examen físico presenta hemiparesia derecha, fiebre de 37,8 grados celsius y la auscultación cardiaca muestra un ritmo regular en 2 tiempos, con un soplo sistólico IV/VI en el ápex. Su sedimento de orina muestra hematuria microscópica. El diagnóstico más probable es:**

A) Absceso cerebral
B) Tuberculosis meníngea
C) Meningitis bacteriana
D) Endocarditis bacteriana
E) Leucemia mieloide aguda

PREGUNTA 4 1.04.2.007

4. **Un paciente de 62 años con neumonía adquirida en la comunidad grave evoluciona con taquipnea (FR 28 rpm), compromiso de conciencia y PA 80/50 mmHg. A pesar de la administración de 2.000 mL de solución salina al 0.9% en 90 minutos, la PAM persiste en 58 mmHg y el lactato sérico se reporta en 3.6 mmol/L. ¿Cuál es la conducta farmacológica inmediata más indicada?**

A) Iniciar infusión continua de dopamina a dosis beta
B) Iniciar infusión de noradrenalina con meta de PAM ≥ 65 mmHg
C) Administrar un bolo de 100 mg de hidrocortisona EV antes de vasopresores
D) Continuar la carga de cristaloides con 2.000 mL adicionales en 1 hora
E) Iniciar infusión de bicarbonato de sodio 2/3 molar

PREGUNTA 5 1.04.2.007

5. **¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos forma parte del score qSOFA (quick SOFA) para la identificación rápida de sepsis en el servicio de urgencia?**

A) Temperatura axilar > 38.3 °C o < 36.0 °C
B) Leucocitosis > 12.000/mm³ o baciliformes > 10%
C) Frecuencia respiratoria ≥ 22 respiraciones por minuto
D) Frecuencia cardíaca > 90 latidos por minuto
E) Diuresis horaria < 0.5 mL/kg/h

PREGUNTA 6 1.04.2.006

6. **Mujer de 23 años, con cuadro de 24 horas de evolución de compromiso del estado general, fiebre y soñolencia progresiva. Al examen físico destaca con temperatura de 38,5°C, petequias y equimosis en extremidades, rigidez de nuca sin focalización neurológica. El diagnóstico más probable es:**

A) Meningitis tuberculosa
B) Meningitis meningococica
C) Meningitis neumocócica
D) Meningitis por listeria
E) Meningitis herpética

PREGUNTA 7 1.04.2.006

7. Hombre de 58 años es traído a urgencias con fiebre de 39 °C, rigidez de nuca y sopor. Al examen se constata hemiparesia braquiocrural derecha leve y signo de Babinski ipsilateral. ¿Cuál es la conducta médica más adecuada a seguir?

A) Realizar punción lumbar de urgencia de inmediato y esperar el Gram para iniciar fármacos
B) Tomar hemocultivos, administrar dexametasona y antibióticos EV de inmediato, y luego solicitar TAC cerebral
C) Trasladar a TAC cerebral de inmediato sin administrar fármacos para no interferir con los cultivos
D) Iniciar infusión de manitol al 15% y diferir todo estudio invasivo por 24 horas
E) Administrar ceftriaxona en dosis única intramuscular y enviar a domicilio con control en 12 horas

PREGUNTA 8 1.04.2.006

8. Se recibe el informe del citoquímico de LCR de un joven de 21 años previamente sano con fiebre y rigidez de nuca: aspecto transparente, leucocitos 180/mm³ con 88% de mononucleares, glucosa en LCR 62 mg/dL (glicemia sérica simultánea 98 mg/dL) y proteínas 68 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Meningitis bacteriana por Streptococcus pneumoniae
B) Meningitis bacteriana por Listeria monocytogenes
C) Meningitis viral (aséptica)
D) Meningitis tuberculosa en fase avanzada
E) Meningitis fúngica por Cryptococcus neoformans

PREGUNTA 9 1.04.2.006

9. Un paciente de 65 años, consulta por fiebre y cefalea de 3 días de evolución, a lo que luego se agrega desorientación. Al examen físico se aprecia confuso, con temperatura 38,5 grados Celsius, FC: 95x' y PA: 110/70 mmHg. En su examen neurológico se aprecia rigidez de nuca, por lo que realiza punción lumbar, que da salida a un líquido cefalo- rraquídeo con 610 células por mm3, con 90% de polimorfonucleares, glucosa: 26 mg/dl y proteínas 123 mg/dl. Además, la tinción de Gram muestra visualización de diplococos gramnegativos. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Ceftriaxona endovenosa
B) Cloxacilina endovenosa
C) Vancomicina endovenosa
D) Imipenem endovenoso
E) Ciprofloxacino oral

PREGUNTA 10 1.04.2.001

10. Una mujer de 35 años consulta por fiebre de 38.5 °C, cefalea y desorientación de 48 horas. Durante la anamnesis presenta alucinaciones olfatorias y afasia de comprensión. La TAC cerebral inicial sin contraste no muestra lesiones evidentes. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?

A) Iniciar Aciclovir endovenoso de inmediato
B) Indicar tratamiento con Ceftriaxona y Vancomicina EV y observar
C) Esperar el resultado de la PCR viral en LCR antes de indicar antivirales
D) Iniciar Dexametasona oral y enviar a domicilio con reposo
E) Solicitar electroencefalograma ambulatorio para descartar pseudocrisis

PREGUNTA 11 1.04.2.001, 1.04.2.002

11. Una mujer de 35 años consulta por fiebre de 38.5 °C, cefalea y desorientación de 48 horas. Durante la anamnesis presenta alucinaciones olfatorias y afasia de comprensión. La TAC cerebral inicial sin contraste no muestra lesiones evidentes. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?

A) Iniciar Aciclovir endovenoso de inmediato
B) Indicar tratamiento con Ceftriaxona y Vancomicina EV y observar
C) Esperar el resultado de la PCR viral en LCR antes de indicar antivirales
D) Iniciar Dexametasona oral y enviar a domicilio con reposo
E) Solicitar electroencefalograma ambulatorio para descartar pseudocrisis

PREGUNTA 12 1.04.2.001, 1.04.2.002

12. ¿Cuál de los siguientes esquemas antibióticos empíricos es el de elección para el tratamiento de un absceso cerebral secundario a una otitis media crónica no complicada con neurocirugía previa?

A) Ceftriaxona + Metronidazol EV
B) Ciprofloxacino + Clindamicina oral
C) Vancomicina + Gentamicina EV
D) Ampicilina en monoterapia EV
E) Cefazolina + Dexametasona EV

PREGUNTA 13 1.04.2.002

13. Un paciente de 43 años, presenta un cuadro clínico de fiebre de 4 días de evolución, asociado a cefalea. Hoy se agrega desorientación y confusión, convulsionando en dos oportunidades antes de consultas. La TAC de cerebro muestra una zona hiperdensa en el lóbulo temporal izquierdo. Se realiza punción lumbar, con 130 células por mm3, 85% mononucleares, glucosa: 75 mg/dl (glicemia 90 mg/dl), proteínas 100 mg/dl, con Pandy (+), látex negativo y ausencia de bacterias en la tinción de Gram. Los cultivos están pendientes. El diagnóstico más probable es:

A) Meningitis bacteriana aguda
B) Meningitis tuberculosa
C) Meningoencefalitis herpética
D) Meningitis por enterovirus
E) Meningitis por VIH

PREGUNTA 14 1.04.2.004

14. Un paciente diabético de 52 años es evaluado en el box de reanimación por una lesión eritematosa en el muslo derecho con marcado edema y dolor intenso. A la palpación se detecta crepitación subcutánea y se aprecian flictenas hemorrágicas en el centro de la lesión. El paciente se encuentra febril (39 °C) e hipotenso (PA 80/50 mmHg). ¿Cuál es la conducta prioritaria en este momento?

A) Solicitar resonancia magnética nuclear urgente del muslo para evaluar la profundidad del compromiso
B) Trasladar de inmediato a pabellón para exploración y desbridamiento quirúrgico extenso
C) Iniciar Cloxacilina 2 g EV y reevaluar los límites del eritema en 12 horas
D) Realizar punción aspirativa con aguja fina en la zona crepitante para cultivo y esperar resultado
E) Administrar corticoides endovenosos a dosis altas para reducir el edema de partes blandas

PREGUNTA 15 1.04.2.004, 1.04.2.005

15. Un paciente diabético de 52 años es evaluado en el box de reanimación por una lesión eritematosa en el muslo derecho con marcado edema y dolor intenso. A la palpación se detecta crepitación subcutánea y se aprecian flictenas hemorrágicas en el centro de la lesión. El paciente se encuentra febril (39 °C) e hipotenso (PA 80/50 mmHg). ¿Cuál es la conducta prioritaria en este momento?

A) Solicitar resonancia magnética nuclear urgente del muslo para evaluar la profundidad del compromiso
B) Trasladar de inmediato a pabellón para exploración y desbridamiento quirúrgico extenso
C) Iniciar Cloxacilina 2 g EV y reevaluar los límites del eritema en 12 horas
D) Realizar punción aspirativa con aguja fina en la zona crepitante para cultivo y esperar resultado
E) Administrar corticoides endovenosos a dosis altas para reducir el edema de partes blandas

PREGUNTA 16 1.04.2.004, 1.04.2.005

16. Un paciente de 38 años consulta por aumento de volumen doloroso cervical anterior y submandibular de 48 horas de evolución, posterior a la extracción del tercer molar inferior izquierdo. Al examen se observa cuello en embudo, elevación de la lengua contra el paladar duro, trismus moderado, voz engolada y estridor inspiratorio intermitente. ¿Cuál es la prioridad médica inmediata?

A) Asegurar la vía aérea de forma inmediata mediante intubación guiada o traqueostomía
B) Solicitar TAC de cuello con contraste para drenaje percutáneo
C) Administrar antibióticos orales con Amoxicilina/Clavulánico y analgesia
D) Realizar laringoscopía indirecta con espejo en el box dental
E) Indicar nebulizaciones con adrenalina racémica y hospitalizar en sala básica

PREGUNTA 17 1.04.2.005

17. Un paciente de 53 años, diabético mal controlado, presenta una lesión en la pierna derecha, desde hace 2 días, que se ha extendido hasta alcanzar un gran tamaño y se ha asociado a malestar general y fiebre. Al examen físico tiene T°: 39,0°C, FC: 115x', PA: 90/60 mmHg. Además, se aprecia la lesión eritematosa de 20 cm, con zonas violáceas y bulas en su superficie. El diagnóstico más probable es:

A) Erisipela
B) Herpes zóster
C) Pioderma gangrenoso
D) Fasceítis necrotizante
E) Celulitis bacteriana

PREGUNTA 18 1.04.2.005

18. Un paciente de 48 años, diabético mal controlado, presenta una lesión en el muslo derecho, desde hace 5 días, que ha crecido y se ha asociado a malestar general y fiebre. Al examen físico tiene T°: 39,0°C, FC: 115x', PA: 90/60 mmHg y se aprecia la lesión de 20 cm de aspecto eritemato-violáceo, con bulas en su superficie. El diagnóstico más probable es:

A) Erisipela
B) Herpes zóster
C) Ántrax
D) Fasceítis necrotizante
E) Miositis necrotizante

BLOQUE 2 SALUD PÚBLICA, PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN E IAAS

PREGUNTA 19 1.04.1.009

19. Una paciente está en tratamiento con ciprofloxacino por una infección urinaria. Al séptimo día inicia diarrea acuosa, abundante, asociada a dolor abdominal. Al axamen físico se constata dolor a la palpación abdominal, sin irritación peritoneal, con aumento de los ruidos hidroaéreos. Los leucocitos fecales resultan positivos. ¿Cuál es el agente etiológico?

A) Escherichia coli
B) Clostridium difficile
C) Shiguella flexneri
D) Rotavirus
E) Campilobacter jejuni

PREGUNTA 20 1.04.1.009

20. Paciente de 70 años, diabético en tratamiento farmacológico y hospitalizado por neumonía desde hace 5 días, comienza desde ayer con cuadro de deposiciones diarreicas acuosas asociado a desorientación temporoespacial. Al examen físico destaca abdomen doloroso a palpación profunda, con ruidos hidroaéreos aumentados y ausencia de irritación peritoneal. Se solicita coprocultivo que se informa negativo y leucocitos fecales positivos. El tratamiento de elección en este caso es:

A) Hidratación por vía oral abundante
B) Metronidazol oral
C) Ciprofloxacino oral
D) Clindamicina ev
E) Probióticos orales

PREGUNTA 21 1.04.1.009

21. Una mujer de 28 años, puérpera de 2 meses, con 3 semanas de diarreas con presencia de sangre y dolor abdominal difuso leve. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con abdomen blando, sensible a la palpación profunda, sin signos de irritación peritoneal, con meteorismo. El diagnóstico más probable es:

A) Diarrea debida a Clostridium difficile
B) Colitis ulcerativa
C) Enfermedad de Cröhn
D) Colitis inespecífica
E) Shigellosis

PREGUNTA 22 1.04.1.009

22. Paciente con antecedente de diverticulitis hace 10-15 días tratada con ATB oral (ciprofloxacino + metronidazol), consulta SU por diarrea múltiples episodios, con pujo y tenesmo, fiebre? dolor y sangrado: a. Diarrea por clostridium (sg yo era un cuadro clásico de diarrea por CD 2° a uso de ATB) b. Reagudización de diverticulitis por rectitis c. Absceso diverticular no puede ser CU? - el pujo y tenesmo no orientaría a CU? Vi una similar en una reconstrucción y era CU x eso,, era muy vieja para ser CU

A) Staphylococcus aureus
B) Streptococcus pneumoniae
C) Escherichia coli
D) Pseudomonas aeruginosa
E) Klebsiella pneumoniae

PREGUNTA 23 1.04.1.029

23. [ATENCIÓN PRIMARIA: Enfermedad leve moderada por SARS Cov 2 COVID 19 · 1.04.1.029] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Enfermedad leve moderada por SARS Cov 2 COVID 19. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 24 1.04.2.011

24. [URGENCIA: Enfermedad grave por SARS Cov 2 COVID 19 · 1.04.2.011] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Enfermedad grave por SARS Cov 2 COVID 19. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 25 1.04.3.001, 1.04.3.009, 1.04.3.010

25. Médica de 30 años sufre accidente cortopunzante con aguja de paciente cuya serología VIH es desconocida. Tras el lavado profuso de la herida, ¿cuál es la conducta más adecuada a seguir?

A) Esperar resultado del ELISA del paciente fuente antes de decidir
B) Ofrecer de inmediato triterapia antirretroviral profiláctica (PEP) por 28 días a 6 semanas
C) Simplemente observar ya que la fuente probablemente es VIH negativa
D) Solicitar PCR para VIH al trabajador de salud de inmediato y esperar resultado
E) Iniciar monoterapia con zidovudina por 4 semanas

PREGUNTA 26 1.04.3.001, 1.04.3.009, 1.04.3.010

26. Niño de 8 años, contacto intradomiciliario de padre con tuberculosis bacilífera. Baciloscopía negativa, radiografía normal, PPD 6 mm. ¿Cuál es la conducta?

A) Iniciar tratamiento antituberculoso completo con 4 fármacos
B) No requiere profilaxis ya que el PPD es negativo (< 10 mm)
C) Isoniazida por 3 meses y controlar con nuevo PPD al término
D) Isoniazida por 6 meses sin necesidad de control posterior
E) Vacunar con BCG y observar evolución

PREGUNTA 27 1.04.2.009

27. Un hombre de 28 años despierta en una cabaña de veraneo y encuentra un murciélago vivo volando en su habitación. No presenta heridas evidentes ni recuerda haber sido mordido. ¿Cuál es la conducta inmediata recomendada?

A) Observar al paciente de forma ambulatoria y consultar solo si presenta fiebre o cefalea
B) Iniciar vacunación antirrábica completa e inmunoglobulina antirrábica de inmediato
C) Capturar al murciélago para observarlo vivo durante 10 días
D) Administrar profilaxis con amoxicilina y citar a curaciones diarias
E) Descartar el riesgo de rabia dado que no existen lesiones cortantes visibles

PREGUNTA 28 1.04.2.009, 1.04.3.002, 1.04.3.008, 1.04.3.012

28. Un hombre de 28 años despierta en una cabaña de veraneo y encuentra un murciélago vivo volando en su habitación. No presenta heridas evidentes ni recuerda haber sido mordido. ¿Cuál es la conducta inmediata recomendada?

A) Observar al paciente de forma ambulatoria y consultar solo si presenta fiebre o cefalea
B) Iniciar vacunación antirrábica completa e inmunoglobulina antirrábica de inmediato
C) Capturar al murciélago para observarlo vivo durante 10 días
D) Administrar profilaxis con amoxicilina y citar a curaciones diarias
E) Descartar el riesgo de rabia dado que no existen lesiones cortantes visibles

PREGUNTA 29 1.04.2.009, 1.04.3.002, 1.04.3.008, 1.04.3.012

29. Una mujer de 45 años consulta tras cortarse la mano con una lata oxidada en su patio. Su esquema de vacunación contra el tétanos está al día, habiendo recibido su última dosis de refuerzo hace 3 años. ¿Cuál es la indicación correcta?

A) Aseo quirúrgico local de la herida sin necesidad de vacuna ni inmunoglobulina
B) Administrar refuerzo con toxoide tetánico (dT)
C) Administrar inmunoglobulina antitetánica (IGH-T) en dosis de 250 UI
D) Administrar vacuna dT + inmunoglobulina antitetánica
E) Iniciar profilaxis antibiótica con ciprofloxacino por 10 días

PREGUNTA 30 1.04.1.015

30. ¿Cuál de las siguientes enfermedades infecciosas transmisibles requiere de forma estricta que el paciente sea hospitalizado en una habitación individual con presión negativa y que el personal de salud utilice mascarilla N95?

A) Meningitis aguda por Neisseria meningitidis
B) Tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva
C) Colitis pseudomembranosa por Clostridioides difficile
D) Coqueluche por Bordetella pertussis
E) Infección urinaria por Klebsiella pneumoniae productora de BLEE

PREGUNTA 31 1.04.1.015, 1.04.3.005

31. ¿Cuál de las siguientes enfermedades infecciosas transmisibles requiere de forma estricta que el paciente sea hospitalizado en una habitación individual con presión negativa y que el personal de salud utilice mascarilla N95?

A) Meningitis aguda por Neisseria meningitidis
B) Tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva
C) Colitis pseudomembranosa por Clostridioides difficile
D) Coqueluche por Bordetella pertussis
E) Infección urinaria por Klebsiella pneumoniae productora de BLEE

PREGUNTA 32 1.04.1.015, 1.04.3.005

32. Un paciente de 58 años en hemodiálisis por fístula nativa en maduración es portador de un catéter tunelizado yugoslavo. Consulta por fiebre de 38.8 °C post-diálisis. Los hemocultivos periféricos y del catéter resultan positivos para Candida albicans. ¿Cuál es la conducta terapéutica correcta respecto al catéter?

A) Mantener el catéter e iniciar fluconazol endovenoso con técnica de sellado de catéter
B) Retirar inmediatamente el catéter y administrar terapia antifúngica sistémica
C) Recambiar el catéter sobre una guía de alambre en el mismo sitio
D) Observar por 48 horas tras iniciar antifúngicos y retirar solo si persiste la fiebre
E) Instilar etanol al 70% por los lúmenes y mantener el catéter para diálisis

PREGUNTA 33 1.04.1.007

33. Un grupo de colegas de trabajo presenta náuseas y vómitos severos unas 3 horas después de compartir arroz frito recalentado en un almuerzo de oficina. No presentan fiebre ni deposiciones diarreicas. ¿Cuál es el patógeno causal más probable?

A) Salmonella enteritidis
B) Bacillus cereus (forma emética)
C) Clostridium perfringens
D) Escherichia coli enterotoxigénica
E) Campylobacter jejuni

PREGUNTA 34 1.04.1.007, 1.04.1.026

34. Un grupo de colegas de trabajo presenta náuseas y vómitos severos unas 3 horas después de compartir arroz frito recalentado en un almuerzo de oficina. No presentan fiebre ni deposiciones diarreicas. ¿Cuál es el patógeno causal más probable?

A) Salmonella enteritidis
B) Bacillus cereus (forma emética)
C) Clostridium perfringens
D) Escherichia coli enterotoxigénica
E) Campylobacter jejuni

PREGUNTA 35 1.04.1.007, 1.04.1.026

35. Una mujer de 52 años es llevada a urgencias por presentar visión doble (diplopía), caída de los párpados y dificultad para tragar de inicio progresivo hace 24 horas, agregándose debilidad en extremidades superiores. Refiere haber consumido conservas caseras de espárragos el día anterior. Al examen físico se constata ptosis palpebral bilateral, midriasis arreactiva y tetraparesia flácida simétrica con reflejos osteotendíneos disminuidos. La sensibilidad es normal y está afebril. ¿Cuál es la conducta terapéutica inmediata?

A) Iniciar infusión de plasmaféresis por sospecha de Síndrome de Guillain-Barré
B) Hospitalizar en UCI, monitorizar mecánica ventilatoria y administrar antitoxina botulínica
C) Administrar Ceftriaxona 2 g EV por sospecha de meningitis bacteriana
D) Indicar tratamiento con Piridostigmina oral por probable crisis miasténica
E) Administrar bolo de metilprednisolona EV por sospecha de esclerosis múltiple

PREGUNTA 36 1.04.1.026

36. Paciente adulto con dolor abdominal, diarrea + fiebre x campylobacter, ¿cual es el tratamiento?: a. Azitromicina

B) Hidratacion + probioticos
C) Ciprofloxacino
C) Staphylococcus aureus
D) Streptococcus pneumoniae
E) Escherichia coli

BLOQUE 3 INFECCIONES CRÓNICAS, RETROVIRALES Y GRANULOMATOSAS

PREGUNTA 37 1.04.1.005

37. [ATENCIÓN PRIMARIA: Candidiasis oral y esofágica · 1.04.1.005] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Candidiasis oral y esofágica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 38 1.04.1.014

38. Un paciente de 37 años consulta por fiebre y malestar general de dos días de evolución, asociado a odinofagia. Al examen físico, tiene FC: 96x', PA: 110/70 mmHg, T°: 38,0°C. Se observan úlceras orales, se palpan adenopatías cervicales bilaterales y se observa un exantema maculopapular eritematoso con distribución predominante en el tronco. Su examen cardiopulmonar es normal. Al examen neurológico, presenta algún grado de confusión y se palpa rigidez de nuca esbozada. Presenta serología negativa para VIH y para virus de Epstein Barr y se realiza una punción lumbar, que da salida a líquido cefalorraquídeo con pleocitosis de predominio mononuclear y glucorraquia de 55 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Primoinfección por VIH
B) Meningoencefalitis por citomegalovirus
C) Meningitis bacteriana aguda
D) Neurosífilis
E) Mononucleosis infecciosa

PREGUNTA 39 1.04.1.014

39. Un joven de 24 años se realiza un test rápido visual para VIH en una campaña universitaria, el cual resulta reactivo. ¿Cuál es la conducta médica normativa que se debe seguir en el sistema de salud chileno?

A) Informar al paciente que tiene infección por VIH confirmada e iniciar de inmediato el tratamiento con antirretrovirales
B) Tomar una segunda muestra de sangre venosa y derivarla al Instituto de Salud Pública (ISP) para confirmación
C) Solicitar carga viral para VIH y dar por confirmado el diagnóstico si esta supera las 1.000 copias/mL
D) Repetir el test rápido visual en 3 meses para descartar el período de ventana
E) Derivar a infectología con diagnóstico de SIDA etapa C3

PREGUNTA 40 1.04.1.014

40. ¿Cuál es el esquema antirretroviral de primera línea preferente para el inicio de tratamiento en pacientes adultos con diagnóstico confirmado de infección por VIH en Chile según la guía ministerial vigente?

A) Zidovudina + Lamivudina + Nevirapina
B) Tenofovir disoproxilo + Lamivudina + Dolutegravir
C) Abacavir + Emtricitabina + Lopinavir/Ritonavir
D) Efavirenz + Zidovudina + Atazanavir
E) Tenofovir alafenamida en monoterapia

PREGUNTA 41 1.04.1.019

41. Un paciente de 41 años, diabético tipo 1, consulta por fiebre, asociado a rinorrea purulenta y enrojecimiento facial. Al examen físico, se observa eritema de la mejilla izquierda y de la punta de la nariz, con una zona necrótica en el ala nasal. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Stafilococcus aureus
B) Candida albicans
C) Streptococcus pyogenes
D) Mucor
E) Pseudomona aureginosa

PREGUNTA 42 1.04.1.019, 1.04.3.006

42. Un paciente de 38 años con VIH y recuento de CD4 de 85 células/mm³ es diagnosticado de neumonía por Pneumocystis jirovecii. Los gases arteriales respirando aire ambiental muestran una PaO2 de 58 mmHg. Además del tratamiento antimicrobiano con Cotrimoxazol a dosis altas, ¿cuál de las siguientes medidas farmacológicas reduce la mortalidad?

A) Iniciar infusión de N-acetilcisteína como antioxidante alveolar
B) Administrar corticoides sistémicos (Prednisona) antes o junto con el antibiótico
C) Indicar tratamiento concomitante con Azitromicina para cobertura de bacterias atípicas
D) Asociar Ganciclovir por probable coinfección con Citomegalovirus
E) Iniciar diuréticos de asa para reducir el edema alveolar

PREGUNTA 43 1.04.1.019, 1.04.3.006

43. Hombre de 31 años con VIH y abandono de terapia presenta cefalea holocraneana y hemiparesia faciobraquial derecha de 5 días de evolución. Su recuento de CD4 es de 45 células/mm³. La RMN cerebral con contraste muestra tres lesiones nodulares con captación en anillo y edema circundante localizadas en el tálamo y ganglios basales izquierdos. ¿Cuál es la conducta médica inicial más adecuada?

A) Indicar biopsia estereotáxica urgente de la lesión talámica
B) Iniciar radioterapia holocraneana por sospecha de linfoma primario del SNC
C) Iniciar tratamiento empírico para Toxoplasmosis con Sulfadiazina + Pirimetamina y evaluar respuesta en 10-14 días
D) Administrar anfotericina B liposomal en monoterapia EV
E) Indicar tratamiento antituberculoso con 4 fármacos por 12 meses

PREGUNTA 44 1.04.1.028

44. Un paciente de 54 años, con antecedente de artri8s reumatoide severa, inicia tratamiento con cor8coides sistémicos y terapia biológica, por lo que se realiza estudio de tuberculosis latente con PPD, el que resulta posi8vo, indicándose tratamiento con isoniacida por 6 meses, permaneciendo asintomá8co. Un año después consulta por lumbago muy intenso, EVA 8/10, de 10 días de evolución, que ha empeorado en los úl8mos días y no ha respondido a analgésicos. En el examen Fsico el dolor limita los movimientos de flexoextensión. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 30% con hemoglobina: 10 g/dL, glóbulos blancos: 12.000/mm³, plaquetas: 480.000/mm³ y VHS: 80 mm/h. La radiograFa de tórax es normal. ¿Cuál es el examen más adecuado para evaluar a este paciente?

A) Radiogra:a de columna lumbar
B) Resonancia magné2ca nuclear lumbar
C) Cin2gra:a ósea
D) ELISPOT
E) PET-scan

PREGUNTA 45 1.04.1.028, 1.04.3.009

45. Un paciente de 35 años consulta por dolor torácico pleurítico y disnea. La toracocentesis diagnóstica obtiene un líquido pleural de aspecto cetrino con recuento de 2.400 leucocitos/mm³, 88% mononucleares, glucosa 48 mg/dL, proteínas 4.8 g/dL y nivel de Adenosina Deaminasa (ADA) de 54 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Empiema paraneumónico complicado por Streptococcus pneumoniae
B) Pleuritis tuberculosa
C) Derrame pleural por insuficiencia cardíaca descompensada
D) Mesotelioma pleural maligno
E) Lupus eritematoso sistémico con serositis

PREGUNTA 46 1.04.1.028, 1.04.3.009

46. Un paciente de 28 años que inició tratamiento antituberculoso hace 3 semanas consulta alarmado porque su orina y saliva se han tornado de color anaranjado intenso. No refiere molestias urinarias, fiebre ni prurito. Las pruebas hepáticas son normales. ¿Cuál es la conducta médica indicada?

A) Suspender de inmediato todo el esquema antituberculoso por sospecha de falla hepática
B) Tranquilizar al paciente, explicar que es un efecto farmacológico benigno de la rifampicina y continuar el esquema
C) Reemplazar la rifampicina por levofloxacino
D) Solicitar sedimento de orina y urocultivo por sospecha de hematuria macroscópica
E) Reducir la dosis de isoniazida a la mitad

PREGUNTA 47 1.04.1.023

47. Un paciente es diagnosticado de infección por VIH, hace 3 meses. Está en etapa A3 e inició tratamiento con triterapia antirretroviral al momento del diagnóstico. Consulta ahora por aparición de placas pruriginosas en el tronco, más algunas lesiones similares en las palmas y plantas. Además tiene una lesión parecida en la cara interna de la mejilla derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Pitiriasis rosada
B) Pitiriasis versicolor
C) Síndrome pie mano boca
D) Sífilis secundaria
E) Reacción adversa a la triterapia antirretroviral

PREGUNTA 48 1.04.1.023

48. Un hombre de 24 años consulta por un exantema eritematoso difuso en tronco que compromete francamente las palmas de las manos y las plantas de los pies, sin prurito, de 1 semana de evolución. Hace 2 meses recuerda haber tenido una úlcera indolora en el pene que desapareció espontáneamente. El VDRL es reactivo 1:64. ¿Cuál es el tratamiento de elección para este paciente?

A) Penicilina Benzatina 2.400.000 UI IM en dosis única
B) Penicilina Benzatina 2.400.000 UI IM semanal por 3 semanas consecutivas
C) Ceftriaxona 1 g EV diario por 14 días
D) Doxiciclina 100 mg cada 12 horas oral por 7 días
E) Azitromicina 1 g oral en dosis única

PREGUNTA 49 1.04.1.023

49. **Una mujer de 26 años con embarazo de 14 semanas presenta un VDRL de tamizaje reactivo 1:16, confirmado mediante FTA-ABS reactivo. La paciente refiere ser alérgica confirmada a la penicilina (presentó shock anafiláctico previo). ¿Cuál es la conducta médica indicada para prevenir la sífilis congénita?**

A) Indicar tratamiento con Doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 14 días
B) Hospitalizar para desensibilización oral a la penicilina y luego administrar Penicilina Benzatina
C) Administrar Eritromicina oral 500 mg cada 6 horas por 14 días
D) Diferir todo tratamiento antibiótico hasta después del parto para evitar teratogenia
E) Administrar Ceftriaxona 1 g diario intramuscular por 10 días

PREGUNTA 50 1.04.1.010

50. **Un paciente de 24 años mantiene relación sexual casual hace 7 días, con penetración vaginal, sin protección evolucionando con disuria, sin otros síntomas. Al examen físico y genital, no hay alteraciones. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Mycoplasma genitalium
B) Ureaplasma urealyticum
C) Chlamydia trachomatis
D) Trichomona vaginalis
E) Escherichia coli

PREGUNTA 51 1.04.1.010

51. **Un hombre de 25 años consulta por disuria y secreción uretral purulenta abundante. La tinción de Gram de la secreción demuestra diplococos Gram negativos intracelulares. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea más adecuado?**

A) Ceftriaxona 500 mg IM en dosis única en monoterapia
B) Ceftriaxona 500 mg IM dosis única + Doxiciclina 100 mg cada 12 h oral por 7 días
C) Ciprofloxacino 500 mg oral en dosis única
D) Azitromicina 500 mg diarios por 3 días
E) Penicilina Benzatina 2.400.000 UI IM en dosis única

PREGUNTA 52 1.04.1.010

52. **Una mujer de 22 años consulta por intenso dolor vulvar y ardor al orinar de 3 días de evolución. Al examen ginecológico se aprecian múltiples vesículas agrupadas y pequeñas úlceras superficiales eritematosas muy sensibles en ambos labios mayores, con adenopatías inguinales dolorosas bilaterales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento indicado?**

A) Chancroide / Ceftriaxona IM
B) Sífilis primaria / Penicilina Benzatina IM
C) Herpes genital primario / Aciclovir oral
D) Linfogranuloma venéreo / Doxiciclina oral
E) Candidiasis vulvovaginal / Fluconazol oral

PREGUNTA 53 1.04.1.010

53. **Un hombre de 34 años consulta por disuria, asociada a secreción uretral purulenta, de un día de evolución. Refiere haber tenido relaciones sexuales sin protección hace una semana. Se realiza tinción de Gram de la secreción uretral, observándose abundantes cocáceas Gram negativas intra y extracelulares. El agente etiológico más probable es:**

A) Neisseria gonorrhoeae
B) Treponema pallidum
C) Chlamydia trachomatis
D) Mycoplasma genitalium
E) Streptococcus pyogenes

PREGUNTA 54 1.04.1.010

54. **Un paciente de 24 años mantiene relaciones sexuales, por vía vaginal, sin protección, evolucionando con disuria, sin otros síntomas. Al examen físico y genital, no hay alteraciones. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Trichomona vaginalis
B) Treponema pallidum
C) Ureaplasma urealyticum
D) Mycoplasma genitalis
E) Chlamydia trachomatis

BLOQUE 4 ZOONOSIS, MEDICINA TROPICAL Y VECTORES

PREGUNTA 55 1.04.1.022

55. **IMAGEN: Parásito intestinal (foto taenia SAGINATA) tratamiento:**

A) Mebendazol
B) Albendazol
C) Praziquantel
D) Ivermectina
E) Derrame pleural

PREGUNTA 56 1.04.2.008

56. **Paciente de 28 años llega a urgencias con fiebre alta, cefalea intensa, mialgias, compromiso respiratorio progresivo y antecedente de trabajo en zona rural del sur de Chile. Hemograma con leucopenia y trombocitopenia. ¿Cuál es el agente causal más probable?**

A) Hantavirus (Sin Nombre)
B) Leptospira interrogans
C) Rickettsia conorii
D) Yersinia pestis
E) Francisella tularensis

PREGUNTA 57 1.04.2.008

57. **Un trabajador forestal de 32 años consulta en un hospital de baja complejidad por cuadro de 3 días de fiebre alta, dolor muscular severo en muslos y sensación de falta de aire. El hemograma muestra Hematocrito de 52%, leucocitos de 16.000/mm³ con 12% de inmunoblastos y recuento de plaquetas de 48.000/mm³. ¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas está formalmente contraindicada o debe evitarse?**

A) Carga masiva de cristaloides con 30 mL/kg en bolo
B) Oxigenoterapia con mascarilla de no reinhalación
C) Monitoreo estricto de diuresis horaria
D) Traslado en ambulancia avanzada con médico
E) Toma de serología para IgM específica

PREGUNTA 58 1.04.2.008

58. **¿Cuál es el mecanismo de transmisión más frecuente del virus Hanta en Chile según la epidemiología nacional?**

A) Picadura del mosquito Aedes aegypti
B) Inhalación de aerosoles contaminados con excretas de ratón colilargo
C) Consumo de carne cruda de cerdo
D) Mordedura directa de murciélago silvestre
E) Contacto sexual con personas asintomáticas

PREGUNTA 59 1.04.4.016

59. **¿Cuál es el método diagnóstico de elección para confirmar o descartar la transmisión congénita de la Enfermedad de Chagas en un recién nacido hijo de madre seropositiva durante sus primeros días de vida?**

A) Serología ELISA IgG en sangre del recién nacido
B) Examen parasitológico directo mediante microhematocrito en sangre fresca
C) Western Blot específico para anticuerpos IgM anti-Trypanosoma cruzi
D) Radiografía de tórax y ecocardiograma neonatal
E) Esperar a los 15 años de vida para realizar tamizaje serológico

PREGUNTA 60 1.04.4.016

60. **Un hombre de 60 años originario de la Región de Coquimbo consulta por constipación crónica pertinaz de años de evolución que se ha agravado en los últimos meses, requiriendo enemas evacuantes periódicos. El enema baritado muestra marcada dilatación del colon sigmoides y recto. El electrocardiograma revela bloqueo completo de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Cáncer de colon izquierdo estenosante
B) Enfermedad de Chagas en fase crónica determinada
C) Enfermedad de Hirschsprung del adulto
D) Colitis ulcerosa de larga data
E) Síndrome de colon irritable variante constipación

PREGUNTA 61 1.04.1.008

61. **Un hombre de 30 años consulta en urgencias por fiebre de 39 °C, cefalea y artralgias intensas tras regresar hace 4 días de un viaje por el Amazonas. El médico sospecha clínicamente infección por virus dengue. ¿Cuál de los siguientes fármacos analgésicos está formalmente contraindicado administrar a este paciente?**

A) Paracetamol
B) Ketoprofeno
C) Dipirona
D) Tramadol
E) Codeína

PREGUNTA 62 1.04.1.008, 1.04.1.018

62. **Un hombre de 30 años consulta en urgencias por fiebre de 39 °C, cefalea y artralgias intensas tras regresar hace 4 días de un viaje por el Amazonas. El médico sospecha clínicamente infección por virus dengue. ¿Cuál de los siguientes fármacos analgésicos está formalmente contraindicado administrar a este paciente?**

A) Paracetamol
B) Ketoprofeno
C) Dipirona
D) Tramadol
E) Codeína

PREGUNTA 63 1.04.1.008, 1.04.1.018

63. **Una mujer de 29 años presenta accesos febriles con calofríos intensos y sudoración profusa cada 48 horas tras regresar de un viaje por el sudeste asiático. La gota gruesa confirma la presencia de trofozoítos de Plasmodium vivax. Tras el tratamiento inicial con Cloroquina y desaparición de los parásitos en sangre, ¿cuál es la conducta necesaria para prevenir recaídas tardías?**

A) Administrar Primaquina oral durante 14 días
B) Continuar Cloroquina en dosis profiláctica por 6 meses
C) Indicar tratamiento con Doxiciclina por 21 días
D) Administrar vacuna antimalárica de refuerzo
E) No requiere fármacos adicionales dado que la cloroquina es curativa

PREGUNTA 64 1.04.1.018

64. **Una paciente realiza un viaje a la selva amazónica y, al cuarto día luego de su regreso, presenta fiebre alta hasta 39,3°C, asociada a cefalea intensa y persistente, con marcado malestar general y mialgias. Se realiza un hemograma, que muestra hematocrito: 24%, hemoglobina: 8 g/dl, glóbulos blancos: 16.000 por mm3, con fórmula diferencial normal, plaquetas: 93.000 por mm3 y VHS: 35 mmHg. El agente etiológico más probable es:**

A) Viruz zika
B) Virus dengue
C) Plasmodium falciparum
D) Salmonella typhi
E) Virus de fiebre amarilla

PREGUNTA 65 1.04.1.013

65. **Un hombre de 40 años presenta un cuadro de dolor abdominal, de 3 meses de evolución, leve, intermitente. Al examen físico presenta leve dolor a la palpación del hipocrondrio derecho, por lo que se solicita una ecografía de abdomen, que visualiza una lesión hepática quística, con paredes visibles y gruesas, de 8 cm. En sus exámenes destaca hemograma con hematocrito y plaquetas normales, con 8.000 blancos, 50% de neutrófilos, 40% de linfocitos, 3% de eosinófilos y 7% de monocitos. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A) IgG para Toxoplasma gondii
B) Serología para hidatidosis
C) Serología para Triquinella spiralis
D) IgG para Fasciola hepática (Distoma)
E) Examen parasitológico seriado de deposiciones

PREGUNTA 66 1.04.1.013, 1.04.1.027

66. **Un paciente de 35 años consulta por fiebre de 38.8 °C, dolor muscular difuso y marcado edema bipalpebral bilateral tras asistir hace dos semanas a una faena clandestina de cerdos donde consumió embutidos artesanales. El hemograma muestra leucocitosis con 38% de eosinófilos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Triquinosis
B) Hidatidosis hepática complicada
C) Fiebre tifoidea
D) Dengue con signos de alarma
E) Enfermedad de Chagas aguda

PREGUNTA 67 1.04.1.013, 1.04.1.027

67. **Durante la realización de una ecografía abdominal de rutina a un campesino de 50 años asintomático, se identifica en el lóbulo hepático derecho una masa quística redondeada de 7 cm de diámetro con tabiques internos y desprendimiento de la membrana germinativa (signo del camalote). ¿Cuál es la complicación aguda más grave que puede presentar este paciente?**

A) Rotura espontánea o traumática con shock anafiláctico grave
B) Transformación a colangiocarcinoma metastásico en menos de 1 año
C) Desarrollo de hipertensión portal con cirrosis hepática descompensada
D) Perforación gástrica con hemorragia digestiva alta masiva
E) Fístula aortoentérica exanguinante

PREGUNTA 68 1.04.1.027

68. **Un paciente de 25 años que vive en una zona rural consulta por cefalea y mialgias intensas de 7 días de evolución, asociadas a malestar general y sensación febril. Al examen Fsico presenta temperatura: 37,5 °C, frecuencia cardíaca: 115 por minuto y presión arterial: 100/60 mmHg. Se solicitan exámenes que muestran PCR 5,6 mg/L (valor normal: menor a 0,5 mg/dl), hemograma con 15.000 glóbulos blancos/mm³, 290.000 plaquetas/mm³ y hematocrito de 35%. En la fórmula diferencial de la serie blanca presenta 40% de eosinófilos. Se solicitan CK, que resultan 2.500 U/L (VN: 30-170 U/L). El estudio ecocardiográfico es compa8ble con miocardi8s aguda. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Fasciolasis hepá2ca
B) Neurosis2cercosis
C) Hida2dosis
D) Infección por Trichinella spiralis
E) Infección por virus Coxsackie

PREGUNTA 69 1.04.1.004

69. **Veterinario expuesto a ganado, dolor articular. Artrocentesis con PMN 70% a. brucelosis b. Fiebre Q**

C) Cultivo de gonococo
D) Hemocultivo
C) Staphylococcus aureus
D) Streptococcus pneumoniae
E) Escherichia coli

PREGUNTA 70 1.04.1.012

70. **Un niño de 7 años presenta fiebre persistente desde hace 7 días, mayor en la tarde, hasta 38,9 °C, asociada a cefalea, anorexia y dolor abdominal. Al examen Fsico 8ene temperatura: 38,2 °C, frecuencia cardíaca: 62x' y frecuencia respiratoria: 15x'. Se palpa abdomen sensible de manera difusa, sin signos peritoneales. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 35%, glóbulos blancos: 3.700/mm³ con 70% segmentados, 9% cayados, 16% linfocitos, 5% monocitos, 0% eosinófilos y VHS 65 mm/h. Su proteína C reac8va resulta 6,9 mg/L (valor normal: < 0,5 mg/L). ¿Cuál es el agente e8ológico más probable?**

A) Brucella melitensis
B) Salmonella typhi
C) Escherichia coli enterotoxigénica
D) Virus de Epstein-Barr
E) Citomegalovirus

PREGUNTA 71 1.04.1.017

71. **Un trabajador agrícola de 38 años consulta por fiebre de 39 °C, cefalea intensa y marcado dolor en las pantorrillas de 5 días de evolución, posterior a realizar labores de limpieza en un canal de regadío con aguas estancadas. Al examen se observa ictericia en escleras y marcada inyección conjuntival bilateral sin secreción purulenta (sufusión conjuntival). El laboratorio muestra Bilirrubina total 8.5 mg/dL de predominio directo, Creatinina 3.2 mg/dL y gases con acidosis metabólica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Leptospirosis ictérica (Síndrome de Weil)
B) Hepatitis viral aguda tipo A
C) Colangitis aguda supurada
D) Fiebre tifoidea complicada
E) Malaria por Plasmodium vivax

PREGUNTA 72 1.04.1.003

72. **Un trabajador de una fábrica procesadora de cueros importados consulta por una lesión en el dorso de la mano izquierda de 4 días de evolución. Al examen se observa una escara negruzca central de consistencia dura, rodeada por vesículas con líquido claro y un marcado edema indurado en toda la mano, sin dolor a la palpación ni secreción purulenta. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea más adecuado?**

A) Ciprofloxacino oral
B) Cefazolina endovenosa
C) Flucloxacilina oral
D) Aciclovir tópico
E) Corticoides sistémicos a dosis altas

BLOQUE 5 INFECCIONES COMUNITARIAS, EXANTEMAS Y HUÉSPED INMUNOCOMPROMETIDO

PREGUNTA 73 1.04.1.001

73. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Adenitis, adenoflegmón · 1.04.1.001] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Adenitis, adenoflegmón. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 74 1.04.1.016

74. **En contexto de un brote de influenza, durante el invierno, un paciente de 22 años presenta un cuadro de rinorrea, congestión nasal, fiebre, mialgias generalizadas y tos seca. Al examen físico presenta 39 grados celsius, con examen pulmonar normal. El tratamiento más adecuado es:**

A) Oseltamivir
B) Zanamivir
C) Aciclovir
D) Valaciclovir
E) Paracetamol

PREGUNTA 75 1.04.1.021

75. **Un niño de 7 años es hospitalizado para manejo quirúrgico de una osteomielitis. El antibiograma informa desarrollo de Staphylococcus aureus con el siguiente antibiograma: ¿Cuál de los siguientes antibióticos es de elección para el manejo inicial?**

A) Flucloxacilina
B) Cefazolina
C) Vancomicina
D) Tetraciclina
E) Cotrimoxazol

PREGUNTA 76 1.04.1.006

76. **Una paciente de 30 años presenta una caída, con erosión de la rodilla derecha. Us- ted la evalúa 3 días después, observándose una zona eritematosa que rodea la herida, de 10 cm de diámetro y bordes parcialmente definidos. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Curación con suero fisiológico y cobertura con apósito
B) Curaciones con povidona yodada
C) Mupirocina tópica
D) Amoxicilina oral por 7 días
E) Cefadroxilo oral por 7 días

PREGUNTA 77 1.04.1.006

77. **Una mujer de 64 años consulta por fiebre de 38.6 °C y dolor en la pierna izquierda. Al examen se observa una placa eritematosa caliente en la cara anteromedial de la pierna, con bordes sobreelevados, nítidos y bien delimitados respecto a la piel sana circundante. ¿Cuál es el microorganismo causal más probable?**

A) Pseudomonas aeruginosa
B) Streptococcus pyogenes
C) Staphylococcus epidermidis
D) Clostridium perfringens
E) Escherichia coli

PREGUNTA 78 1.04.1.006

78. **¿Cuál de los siguientes esquemas antimicrobianos por vía oral es el de primera línea para el tratamiento ambulatorio de una celulitis no complicada de extremidad inferior en un paciente adulto sin alergias?**

A) Ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas
B) Cefadroxilo 500 mg cada 12 horas
C) Metronidazol 500 mg cada 8 horas
D) Gentamicina oral 80 mg cada 8 horas
E) Doxiciclina 100 mg cada 24 horas

PREGUNTA 79 1.04.1.025

79. **Un paciente de 23 años consulta por fiebre de 7 días de evolución asociada a odinofagia intensa y malestar general. Al examen Fsico se observa paciente febril, con temperatura: 38,1 °C, frecuencia cardíaca: 100 por minuto y presión arterial: 118/78 mmHg; presenta faringe eritematosa con amígdalas aumentadas de tamaño, se palpan adenopa`as cervicales anteriores bilaterales y, en el examen abdominal, se palpa el hígado 2 cm por debajo del reborde costal. Se solicitan exámenes, destacando: hemograma con hematocrito 39%, hemoglobina 13 g/dL, VCM 88 fL, glóbulos blancos 15.600/mm³ con 70% linfocitos, 20% neutrófilos y 10% monocitos; pruebas hepá8cas con SGOT: 262 U/L, SGPT: 214 U/L, GGT: 90 U/L, fosfatasas alcalinas: 95 U/L y bilirrubina total: 1,2 mg/dL. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Infección por virus hepa22s A
B) Leucemia aguda
C) Toxoplasmosis aguda
D) Mononucleosis infecciosa
E) Amigdali2s bacteriana

PREGUNTA 80 1.04.1.025

80. **Un universitario de 20 años presenta fiebre de 39 °C, disfagia intensa y astenia de una semana. Se le diagnosticó faringitis estreptocócica hace 3 días y se le administró amoxicilina, presentando al segundo día un exantema eritematoso maculopapular generalizado. Al examen físico destaca faringe con placas pultáceas, adenopatías cervicales posteriores bilaterales y esplenomegalia palpable. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Shock anafiláctico secundario a penicilina
B) Mononucleosis infecciosa por Virus Epstein-Barr
C) Escarlatina por Streptococcus pyogenes
D) Infección aguda por Citomegalovirus
E) Lupus eritematoso sistémico inducido por fármacos

PREGUNTA 81 1.04.1.025

81. **Un recién nacido de 5 días de vida presenta microcefalia, ictericia y hepatoesplenomegalia. La ecografía transfontanelar revela calcificaciones periventriculares y el examen auditivo demuestra hipoacusia neurosensorial bilateral profunda. ¿Cuál es el agente etiológico congénito más probable?**

A) Toxoplasma gondii
B) Citomegalovirus (CMV)
C) Treponema pallidum
D) Virus de la Rubéola
E) Virus Herpes Simplex tipo 2

PREGUNTA 82 1.04.1.011

82. **Hombre de 18 años, sin antecedentes, con cuadro de 3 días de compromiso del estado general, sensación febril, tos y coriza, que durante el último día se ha asociado a prurito generalizado. Al examen físico destaca presencia de lesiones papulares y vesículas muy pruriginosas en tronco y extremidades, no asociado a otros hallazgos. El tratamiento de elección en este caso es:**

A) Clorfenamina oral
B) Aspirina oral
C) Aciclovir oral
D) Vacuna contra virus herpes 3
E) Inmunoglobulina G no específica

PREGUNTA 83 1.04.1.011

83. **Un niño de 5 años presenta dolor faríngeo y fiebre de 38.5 °C. Al examen destaca un exantema micropapular eritematoso difuso que palidece a la presión y tiene un tacto áspero similar a un papel de lija, con acentuación del eritema en los pliegues antecubitales formando líneas transversales que no palidecen (Líneas de Pastia). Se observa lengua con papilas hipertróficas rojas prominentes. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico indicado para este cuadro?**

A) Azitromicina 10 mg/kg/día por 3 días
B) Amoxicilina oral 50 mg/kg/día por 10 días completos
C) Cefuroximo oral por 5 días
D) Ciprofloxacino oral por 7 días
E) No requiere antibióticos por tratarse de una infección viral autolimitada

PREGUNTA 84 1.04.1.011

84. **¿Cuál es el principal objetivo del tratamiento precoz con Inmunoglobulina Endovenosa a altas dosis en un lactante diagnosticado con Enfermedad de Kawasaki?**

A) Prevenir la progresión a glomerulonefritis post-infecciosa
B) Evitar el desarrollo de aneurismas y ectasias en las arterias coronarias
C) Reducir la duración de la descamación periungueal
D) Erradicar la portación nasal de Streptococcus
E) Prevenir la reactivación por virus varicela zóster

PREGUNTA 85 1.04.1.011, 1.04.2.010

85. **Un hombre de 36 años fumador consulta por disnea aguda progresiva y tos con estrías de sangre de 24 horas de evolución. Presenta desde hace 4 días un exantema vesicular polimórfico en cara y tronco compatible con varicela. La saturación de oxígeno es 89% con aire ambiental y la radiografía de tórax muestra infiltrados micronodulares bilaterales difusos. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico prioritario?**

A) Aciclovir endovenoso a dosis de 10 mg/kg cada 8 horas
B) Aciclovir oral 800 mg cada 4 horas
C) Ceftriaxona más Claritromicina endovenosa
D) Inmunoglobulina hiperinmune contra varicela zóster intramuscular
E) Metilprednisolona endovenosa en pulsos

PREGUNTA 86 1.04.1.011, 1.04.2.010

86. Una mujer de 68 años consulta por intenso dolor urente en la hemicara izquierda de 3 días de evolución, asociándose hace 24 horas a la aparición de vesículas en racimo en la frente, el párpado superior y la punta de la nariz (signo de Hutchinson positivo). ¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?

A) Iniciar Aciclovir oral a dosis plenas y solicitar evaluación urgente por Oftalmología
B) Indicar tratamiento con Carbamazepina y analgesia con Paracetamol
C) Aplicar ungüento tópico de corticoides en las lesiones nasales y párpado
D) Administrar vacuna de refuerzo contra herpes zóster
E) Realizar desbridamiento quirúrgico de las vesículas nasales

PREGUNTA 87 1.04.2.010

87. Un hombre de 36 años fumador consulta por disnea aguda progresiva y tos con estrías de sangre de 24 horas de evolución. Presenta desde hace 4 días un exantema vesicular polimórfico en cara y tronco compatible con varicela. La saturación de oxígeno es 89% con aire ambiental y la radiografía de tórax muestra infiltrados micronodulares bilaterales difusos. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico prioritario?

A) Aciclovir endovenoso a dosis de 10 mg/kg cada 8 horas
B) Aciclovir oral 800 mg cada 4 horas
C) Ceftriaxona más Claritromicina endovenosa
D) Inmunoglobulina hiperinmune contra varicela zóster intramuscular
E) Metilprednisolona endovenosa en pulsos

PREGUNTA 88 1.04.1.020

88. Un paciente de 62 años que recibió quimioterapia intensiva hace 8 días por una leucemia mieloide aguda consulta en urgencias por fiebre de 38.7 °C y calofríos. Al examen no se identifica foco infeccioso evidente. El hemograma revela un recuento de leucocitos de 600/mm³ con 30% de neutrófilos totales (RAN 180/mm³). Tras la toma de hemocultivos, ¿cuál es la conducta terapéutica inmediata más adecuada?

A) Iniciar infusión endovenosa de Cefepime 2 g en menos de 60 minutos
B) Administrar Ceftriaxona 2 g EV más Vancomicina y hospitalizar en sala básica
C) Indicar tratamiento con Ciprofloxacino oral y control ambulatorio en 24 horas
D) Esperar el resultado de los hemocultivos para iniciar el antibiótico dirigido
E) Iniciar tratamiento antifúngico con Fluconazol oral en monoterapia

PREGUNTA 89 1.04.1.020, 1.04.1.024

89. Un paciente de 62 años que recibió quimioterapia intensiva hace 8 días por una leucemia mieloide aguda consulta en urgencias por fiebre de 38.7 °C y calofríos. Al examen no se identifica foco infeccioso evidente. El hemograma revela un recuento de leucocitos de 600/mm³ con 30% de neutrófilos totales (RAN 180/mm³). Tras la toma de hemocultivos, ¿cuál es la conducta terapéutica inmediata más adecuada?

A) Iniciar infusión endovenosa de Cefepime 2 g en menos de 60 minutos
B) Administrar Ceftriaxona 2 g EV más Vancomicina y hospitalizar en sala básica
C) Indicar tratamiento con Ciprofloxacino oral y control ambulatorio en 24 horas
D) Esperar el resultado de los hemocultivos para iniciar el antibiótico dirigido
E) Iniciar tratamiento antifúngico con Fluconazol oral en monoterapia

PREGUNTA 90 1.04.1.024

90. Un paciente de 62 años que recibió quimioterapia intensiva hace 8 días por una leucemia mieloide aguda consulta en urgencias por fiebre de 38.7 °C y calofríos. Al examen no se identifica foco infeccioso evidente. El hemograma revela un recuento de leucocitos de 600/mm³ con 30% de neutrófilos totales (RAN 180/mm³). Tras la toma de hemocultivos, ¿cuál es la conducta terapéutica inmediata más adecuada?

A) Iniciar infusión endovenosa de Cefepime 2 g en menos de 60 minutos
B) Administrar Ceftriaxona 2 g EV más Vancomicina y hospitalizar en sala básica
C) Indicar tratamiento con Ciprofloxacino oral y control ambulatorio en 24 horas
D) Esperar el resultado de los hemocultivos para iniciar el antibiótico dirigido
E) Iniciar tratamiento antifúngico con Fluconazol oral en monoterapia

SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

BLOQUE 1 URGENCIAS CRÍTICAS, SEPSIS E INFECCIONES DEL SNC · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 1 — Respuesta: A — Endocarditis bateriana

1.04.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene una endocarditis subaguda por Streptococcus viridans, que se trata con ampicilina o penicilina sódica.

PREGUNTA 2 — Respuesta: A — Endocarditis bateriana

1.04.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Endocarditis protésica precoz (<2 meses post-cirugía): causada por gérmenes hospitalarios, principalmente Staphylococcus aureus y S. epidermidis (estafilococos coagulasa negativos), adquiridos intraoperatoriamente.

PREGUNTA 3 — Respuesta: D — Endocarditis bateriana

1.04.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tanto el soplo, como los fenómenos embólicos, orientan a EBSA (endocarditis bacteriana subaguda; la aguda es menor a 7 días). Ninguna de las opciones puede ser, por no tener relación con la clínica.

PREGUNTA 4 — Respuesta: B

Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora)

1.04.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El paciente se encuentra en shock séptico refractario a fluidos (PAM < 65 mmHg y lactato > 2 mmol/L post-volumen). La recomendación Surviving Sepsis Campaign establece la Noradrenalina como el vasopresor de primera línea para restaurar la presión de perfusión tisular (PAM ≥ 65 mmHg). La dopamina (A) aumenta el riesgo de arritmias ventriculares y mortalidad. Los corticoides (C) se indican solo en shock refractario a dosis altas de noradrenalina. Continuar aportando volumen a ciegas (D) provoca edema pulmonar y mayor falla ventricular.

PREGUNTA 5 — Respuesta: C

Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora)

1.04.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El qSOFA consta exclusivamente de tres parámetros clínicos de fácil evaluación sin requerir exámenes de laboratorio: (1) Frecuencia respiratoria ≥ 22 rpm, (2) Alteración del estado mental (Glasgow < 15), y (3) Presión arterial sistólica ≤ 100 mmHg. La temperatura, taquicardia y leucocitosis (A, B, D) pertenecían a los antiguos criterios de SIRS, los cuales fueron abandonados por su baja especificidad.

PREGUNTA 6 — Respuesta: B

Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

1.04.2.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene un cuadro sugerente de MBA. Las petequias y equimosis son de meningococcemia.

PREGUNTA 7 — Respuesta: B

Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

1.04.2.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La presencia de focalidad neurológica (hemiparesia y Babinski) es una contraindicación formal para la punción lumbar inmediata por riesgo inminente de herniación cerebral fatal. Sin embargo, la regla médica absoluta es que NUNCA se debe postergar el inicio de los antibióticos por la realización de neuroimágenes. La conducta exacta es tomar hemocultivos inmediatos, administrar la Dexametasona EV + Ceftriaxona + Vancomicina + Ampicilina (por ser > 50 años), y proceder de inmediato a la realización del TAC.

PREGUNTA 8 **Respuesta: C**

Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

1.04.2.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El perfil de LCR muestra pleocitosis moderada a expensas de mononucleares/linfocitos, con proteínas levemente aumentadas y GLUCOSA NORMAL (ratio LCR/suero > 0.6). Este patrón es característico de meningitis viral (etiología enterovirus la más frecuente en adultos jóvenes). La bacteriana (A, B) y la tuberculosa/fúngica (D, E) cursan con hipoglucorraquia marcada (consumo patológico de glucosa).

PREGUNTA 9 **Respuesta: A** **Meningitis Aguda Bacteriana y Viral** 1.04.2.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una meningitis por meningococo, que se trata con ceftriaxona o penicilina endovenosas.

PREGUNTA 10 **Respuesta: A**

Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral

1.04.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La presencia de fiebre asociada a síntomas del lóbulo temporal (alucinaciones olfatorias, afasia de comprensión, desorientación) configura una alta sospecha de encefalitis herpética. La TAC cerebral puede ser completamente normal en las primeras 48 a 72 horas. La conducta inmediata y que no admite demora es el inicio de Aciclovir EV (10 mg/kg c/8h), el cual reduce la mortalidad de más de un 70% a menos del 20%.

PREGUNTA 11 **Respuesta: A**

Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral

1.04.2.001, 1.04.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La presencia de fiebre asociada a síntomas del lóbulo temporal (alucinaciones olfatorias, afasia de comprensión, desorientación) configura una alta sospecha de encefalitis herpética. La TAC cerebral puede ser completamente normal en las primeras 48 a 72 horas. La conducta inmediata y que no admite demora es el inicio de Aciclovir EV (10 mg/kg c/8h), el cual reduce la mortalidad de más de un 70% a menos del 20%.

PREGUNTA 12 **Respuesta: A**

Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral

1.04.2.001, 1.04.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Los abscesos cerebrales contiguos secundarios a sinusitis u otitis media crónica son provocados típicamente por flora mixta polimicrobiana: estreptococos aerobios y anaerobios de la cavidad oral/orofaríngea (Bacteroides, Fusobacterium, Peptostreptococcus). El esquema de elección es Ceftriaxona (cruza BHE con excelente cobertura para estreptococos) combinada con Metronidazol (excelente penetración en LCR y tejido necrótico contra anaerobios).

PREGUNTA 13 **Respuesta: C**

Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral

1.04.2.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una meningoencefalitis herpética clásica, con la clínica de compromiso de conciencia (o convulsiones) y la clásica afectación de los lóbulos temporales. La punción sugiere infección viral (glucosa normal: sobre 40; y pleocitosis mononuclear), aunque le falta la presencia de glóbulos rojos, característica del herpes.

PREGUNTA 14 **Respuesta: B**

Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig

1.04.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La presencia de flictenas hemorrágicas, crepitación y shock séptico en una infección de partes blandas es diagnóstica de fascitis necrotizante. La mortalidad se incrementa drásticamente por cada hora de demora quirúrgica. Ningún examen de imagen (A) ni procedimiento diagnóstico menor (D) debe retrasar el ingreso a pabellón. El tratamiento es quirúrgico inmediato (desbridamiento amplio de toda la fascia desvitalizada) asociado a reanimación y antibióticos EV de amplio espectro.

PREGUNTA 15 **Respuesta: B**

1.04.2.004, 1.04.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig

La presencia de flictenas hemorrágicas, crepitación y shock séptico en una infección de partes blandas es diagnóstica de fascitis necrotizante. La mortalidad se incrementa drásticamente por cada hora de demora quirúrgica. Ningún examen de imagen (A) ni procedimiento diagnóstico menor (D) debe retrasar el ingreso a pabellón. El tratamiento es quirúrgico inmediato (desbridamiento amplio de toda la fascia desvitalizada) asociado a reanimación y antibióticos EV de amplio espectro.

PREGUNTA 16 **Respuesta: A**

1.04.2.004, 1.04.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig

El cuadro corresponde a una Angina de Ludwig con signos inminentes de compromiso obstructivo de la vía aérea (estridor inspiratorio, protrusión lingual, cuello en embudo). La causa número uno de muerte en esta patología es la asfixia por colapso de la hipofaringe. La prioridad médica absoluta antes de cualquier estudio radiológico o intervención quirúrgica del foco es el aseguramiento de la vía aérea mediante intubación con fibra óptica o traqueostomía de urgencia.

PREGUNTA 17 **Respuesta: D**

1.04.2.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig

Si bien la parte iniciar del cuadro sugería una erisipela o celulitis (se diferencias fácilmente por los bordes nítidos o difusos, respectivamente), la presencia de zonas violáceas y bulas es sugerente de fasceítis necrotizante (la erisipela también puede tener pequeñas bulas). Lia...

PREGUNTA 18 **Respuesta: D**

1.04.2.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig

Es una fasceítis necrotizante clásica.

BLOQUE 2 SALUD PÚBLICA, PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN E IAAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 19 **Respuesta: B** **Diarrea asociada a antibióticos** 1.04.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Diarrea post-ATB es por C. difficile en el 30% de los casos.

PREGUNTA 20 **Respuesta: B** **Diarrea asociada a antibióticos** 1.04.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Diarrea por ATB, probablemente por C. difficile. Se trata con MTZ. Eso sí, primero se debería confirmar el diagnóstico con la PCR para Clostridium difficile.

PREGUNTA 21 **Respuesta: A** **Diarrea asociada a antibióticos** 1.04.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Seguro recibió antibióticos en el puerperio, por lo que se sospecha la diarrea por C. difficile. Las otras opciones no tienen relación con el antecedente de puerperio.

PREGUNTA 22 **Respuesta: A** **Diarrea asociada a antibióticos** 1.04.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Caso clínico oficial EUNACOM para Diarrea asociada a antibióticos.

PREGUNTA 23 **Respuesta: A**

Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes

1.04.1.029 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Enfermedad leve moderada por SARS Cov 2 COVID 19" (1.04.1.029), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 24 **Respuesta: A**

Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes

1.04.2.011 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Enfermedad grave por SARS Cov 2 COVID 19" como urgencia clínica (1.04.2.011), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 25 **Respuesta: B**

Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes

1.04.3.001, 1.04.3.009, 1.04.3.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Ante un accidente laboral de riesgo biológico con fuente desconocida o seropositiva, la profilaxis post-exposición (PEP) con triterapia debe ofrecerse e iniciarse de forma inmediata (idealmente < 2-4 horas, máximo 72 horas) por 28 días. No se debe postergar el inicio esperando el resultado serológico de la fuente (A), ya que la eficacia decae drásticamente tras las primeras horas.

PREGUNTA 26 **Respuesta: C**

Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes

1.04.3.001, 1.04.3.009, 1.04.3.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En menores de 15 años expuestos a un contacto bacilífero con PPD inicial negativo (< 10 mm en no infectados), la norma chilena indica quimioprofilaxis con Isoniazida de entrada durante 3 meses ("período de ventana inmunológica") y repetir el PPD: si al tercer mes continúa negativo se suspende; si positiviza (viraje), se completan 6 meses de tratamiento.

PREGUNTA 27 **Respuesta: B**

Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico

1.04.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

En Chile, el murciélago es el principal reservorio de rabia. Las mordeduras de murciélago pueden ser indoloras e imperceptibles. Según la norma MINSAL, el hallazgo de un murciélago en la misma habitación donde dormía una persona se considera una exposición de alto riesgo ("contacto no apercibido"). La indicación obligatoria es iniciar de inmediato la vacunación antirrábica completa (esquema de 5 dosis) junto con la administración de Inmunoglobulina antirrábica.

PREGUNTA 28 **Respuesta: B**

Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico

1.04.2.009, 1.04.3.002, 1.04.3.008, 1.04.3.012 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

En Chile, el murciélago es el principal reservorio de rabia. Las mordeduras de murciélago pueden ser indoloras e imperceptibles. Según la norma MINSAL, el hallazgo de un murciélago en la misma habitación donde dormía una persona se considera una exposición de alto riesgo ("contacto no apercibido"). La indicación obligatoria es iniciar de inmediato la vacunación antirrábica completa (esquema de 5 dosis) junto con la administración de Inmunoglobulina antirrábica.

PREGUNTA 29 **Respuesta: A**

1.04.2.009, 1.04.3.002, 1.04.3.008, 1.04.3.012

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico

En un paciente con antecedente fidedigno de vacunación completa cuya última dosis fue administrada hace menos de 5 años, los títulos séricos de anticuerpos antitoxina son óptimos y protectores, incluso ante heridas sucias o tetanígenas. Por ende, solo se requiere aseo prolijo de la herida, sin indicación de toxoide ni de inmunoglobulina.

PREGUNTA 30 **Respuesta: B**

1.04.1.015

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

GES

IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento

La Tuberculosis pulmonar bacilífera activa se transmite mediante aerosoles con núcleos de gotitas microscópicas (< 5 micrones) que permanecen suspendidas en el aire por horas. Requiere aislamiento aéreo estricto con mascarilla de alta filtración (N95) y presión negativa en la habitación para evitar que los aerosoles pasen a los pasillos del hospital. El meningococo y coqueluche (A, D) usan aislamiento por gotitas (mascarilla quirúrgica simple); Clostridioides y bacterias BLEE (C, E) usan aislamiento de contacto.

PREGUNTA 31 **Respuesta: B**

1.04.1.015, 1.04.3.005

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

GES

IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento

La Tuberculosis pulmonar bacilífera activa se transmite mediante aerosoles con núcleos de gotitas microscópicas (< 5 micrones) que permanecen suspendidas en el aire por horas. Requiere aislamiento aéreo estricto con mascarilla de alta filtración (N95) y presión negativa en la habitación para evitar que los aerosoles pasen a los pasillos del hospital. El meningococo y coqueluche (A, D) usan aislamiento por gotitas (mascarilla quirúrgica simple); Clostridioides y bacterias BLEE (C, E) usan aislamiento de contacto.

PREGUNTA 32 **Respuesta: B**

1.04.1.015, 1.04.3.005

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

GES

IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento

La candidemia asociada a catéter venoso central es una infección invasiva de máxima gravedad con formación masiva de biofilm fúngico intra y extraluminal. La guía internacional y las normas de IAAS establecen que el catéter DEBE RETIRARSE INMEDIATAMENTE en toda infección por Candida spp., asociado a terapia antifúngica sistémica (Equinocandina o Fluconazol) y fondo de ojo para descartar endoftalmitis candidiásica.

PREGUNTA 33 **Respuesta: B**

1.04.1.007

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

GES

Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera

Bacillus cereus presenta dos formas clínicas bien diferenciadas: la forma emética (provocada por la toxina termoestable cereulida, con incubación muy corta de 1 a 5 horas y vómitos intensos, clásicamente asociada al arroz frito o recalentado) y la forma diarreica (incubación de 8 a 16 horas, mediada por enterotoxinas lábiles). Salmonella y Campylobacter (A, E) tienen períodos de incubación mayores a 16-24 horas y cursan con fiebre.

PREGUNTA 34 **Respuesta: B**

1.04.1.007, 1.04.1.026

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

GES

Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera

Bacillus cereus presenta dos formas clínicas bien diferenciadas: la forma emética (provocada por la toxina termoestable cereulida, con incubación muy corta de 1 a 5 horas y vómitos intensos, clásicamente asociada al arroz frito o recalentado) y la forma diarreica (incubación de 8 a 16 horas, mediada por enterotoxinas lábiles). Salmonella y Campylobacter (A, E) tienen períodos de incubación mayores a 16-24 horas y cursan con fiebre.

PREGUNTA 35 **Respuesta: B**

1.04.1.007, 1.04.1.026

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

GES

Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera

El antecedente de ingesta de conservas caseras sumado a la clínica de compromiso de pares craneanos (diplopía, ptosis, midriasis) y parálisis flácida descendente sin alteración sensitiva es patognomónico de Botulismo alimentario. El Guillain-Barré (A) es una parálisis típicamente ASCENDENTE (de piernas hacia arriba) y la miastenia (D) no causa midriasis ni disautonomía. La conducta urgente es ingreso a UCI por riesgo de fallo ventilatorio y administración de Antitoxina Botulínica equina inmediata.

PREGUNTA 36 **Respuesta: A**

Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera

1.04.1.026 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 45). Evalúa el manejo clínico de Toxicoinfección alimentaria según directrices MINSAL vigentes.

BLOQUE 3 INFECCIONES CRÓNICAS, RETROVIRALES Y GRANULOMATOSAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 37 **Respuesta: A** **Candidiasis oral y esofágica** 1.04.1.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Candidiasis oral y esofágica" (1.04.1.005), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 38 **Respuesta: A**

Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES)

1.04.1.014 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Síndrome retroviral agudo o primoinfección por VIH: El síndrome retroviral agudo es la primera etapa de la infección por VIH. Se manifiesta clínicamente como un síndrome mononucleósico, que suele incluir fiebre, dolor de garganta, inflamación de los ganglios linfáticos y fatiga. A menudo se acompaña de un exantema rosado. En algunos casos, el síndrome retroviral agudo puede complicarse con meningitis aséptica, de tipo viral, con líquido cefalorraquídeo de predominio de células mononucleares y glucorraquia superior a 40 mg/dL. Durante el período de ventana, que es el tiempo que transcurre entre la infección por VIH y la aparición de anticuerpos detectables en la sangre, la serología para VIH puede ser negativa. Por lo tanto, el examen de elección para diagnosticar el síndrome retroviral agudo es la PCR para VIH o la detección de antígenos del VIH, ya que estas pruebas detectan directamente el virus. En cambio, en la infección crónica por VIH, el diagnóstico se realiza mediante serología (ELISA) y se confirma con Western blot, ya que en esta etapa los anticuerpos contra el VIH ya son detectables en la sangre.

PREGUNTA 39 **Respuesta: B**

Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES)

1.04.1.014 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En Chile, según la Ley 19.779 (Ley del SIDA), ningún examen de tamizaje local (sea test rápido o ELISA de 4ª generación) confiere diagnóstico definitivo. Ante cualquier resultado reactivo, se debe tomar una segunda muestra de sangre y enviarla al ISP para su confirmación oficial mediante Western Blot / Inmunocromatografía. Solo con el informe confirmatorio del ISP se entrega el diagnóstico al paciente y se activa la canasta GES.

PREGUNTA 40 **Respuesta: B**

Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES)

1.04.1.014 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El esquema preferente de primera línea en las guías clínicas GES del MINSAL es la combinación en tableta única diaria de dos inhibidores de transcriptasa reversa nucleósidos (Tenofovir disoproxil fumarato + Lamivudina) asociados a un inhibidor de integrasa de segunda generación (Dolutegravir: TDF/3TC/DTG). Este esquema reemplazó a los regímenes antiguos basados en Efavirenz (asociados a efectos neuropsiquiátricos) y Zidovudina (asociada a mielotoxicidad y anemia severa).

PREGUNTA 41 **Respuesta: D**

Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA

1.04.1.019 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Es una mucormicosis clásica.

PREGUNTA 42 **Respuesta: B**

1.04.1.019, 1.04.3.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA

En la neumonía por Pneumocystis jirovecii, la presencia de una PaO2 < 70 mmHg o un gradiente alvéolo-arterial ≥ 35 mmHg define una forma moderada-severa con alto riesgo de falla ventilatoria. El uso de corticoides sistémicos (Prednisona 40 mg c/12h con pauta descendente por 21 días) reduce a la mitad la necesidad de intubación y la mortalidad intrahospitalaria, al mitigar la respuesta inflamatoria paradójica gatillada por la muerte del hongo.

PREGUNTA 43 **Respuesta: C**

1.04.1.019, 1.04.3.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA

En un paciente con SIDA avanzado (CD4 < 100) que se presenta con múltiples lesiones cerebrales con realce en anillo y predilección por los núcleos de la base, la etiología más frecuente con gran diferencia es la Toxoplasmosis cerebral. La conducta recomendada internacionalmente es iniciar tratamiento empírico antitoxoplasma y repetir la neuroimagen en 10 a 14 días. La biopsia cerebral (A) solo se plantea si el paciente empeora clínicamente o no muestra mejoría radiológica tras 2 semanas (sospecha de Linfoma Primario del SNC).

PREGUNTA 44 **Respuesta: B**

1.04.1.028 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR

La sospecha es una tuberculosis vertebral, conocida como mal de Pox. Es una osteomieliGs, por lo que el examen de elección es la RMN. La cintigrafía es una opción, pero menos específica, por lo que ha sido desplazada por la RMN. La prueba ELISPOT es un IGRA (Interferon-Gamma Release Assay), que se usa en el diagnóstico de la TBC latente, al igual que el PPD y otros IGRAs.

PREGUNTA 45 **Respuesta: B**

1.04.1.028, 1.04.3.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR

Un líquido pleural exudativo con claro predominio mononuclear/linfocítico (> 80%) y una elevación de la enzima Adenosina Deaminasa (ADA) por encima de 40 UI/L tiene una sensibilidad y especificidad superiores al 95% para Pleuritis Tuberculosa en áreas de prevalencia moderada como Chile. El empiema bacteriano (A) cursa con predominio PMN franco y pH < 7.20; la insuficiencia cardíaca (C) produce un trasudado con ADA normal (< 20 UI/L).

PREGUNTA 46 **Respuesta: B**

1.04.1.028, 1.04.3.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR

La Rifampicina y sus metabolitos tienen una coloración rojo-anaranjada intrínseca que tiñe los fluidos corporales (orina, sudor, lágrimas y saliva). Este fenómeno es completamente inocuo, carece de significado patológico y no indica daño hepático ni renal. La conducta es educar y tranquilizar al paciente para asegurar la adherencia al tratamiento, advirtiendo a usuarios de lentes de contacto que estos pueden mancharse de forma permanente.

PREGUNTA 47 **Respuesta: D**

1.04.1.023 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas

Es una sífilis secundaria clásica. Además recordar que el principal factor de riesgo para tener una ETS, es tener otra ETS.

PREGUNTA 48 **Respuesta: A**

1.04.1.023 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas

El paciente cursa con un secundarismo sifilítico (sífilis secundaria con exantema palmoplantar característico y títulos altos de VDRL). La sífilis secundaria forma parte de la Sífilis Precoz (menos de 1 año de evolución desde el contacto infectante). El tratamiento de elección normado por el MINSAL es Penicilina G Benzatina en DOSIS ÚNICA de 2.400.000 UI IM. El esquema de 3 semanas consecutivas (B) se reserva para sífilis latente tardía (> 1 año) o de duración indeterminada.

PREGUNTA 49 **Respuesta: B**

1.04.1.023 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas

La Penicilina es el ÚNICO antibiótico con eficacia demostrada para atravesar la placenta y tratar tanto a la madre como al feto, previniendo la sífilis congénita, el aborto y la muerte fetal in útero. La doxiciclina (A) está formalmente contraindicada en el embarazo por daño dental y óseo fetal. Los macrólidos (C) no cruzan adecuadamente la placenta. Por tanto, ante una embarazada alérgica a la penicilina, la norma nacional e internacional exige desensibilización protocolizada a penicilina y tratamiento posterior con Penicilina Benzatina.

PREGUNTA 50 **Respuesta: C**

1.04.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH

Pregunta difícil, ya que A, B, C y D pueden producir ese cuadro clínico. Sin embargo, la Chlamydia es la causa más frecuente de uretritis, después de la gonorrea (la que bastante purulenta, casi siempre; mientras que las demás pueden no serlo).

PREGUNTA 51 **Respuesta: B**

1.04.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH

Aunque el frotis confirme gonorrea, el tratamiento sindrómico normado por el MINSAL y la CDC exige cobertura combinada para Neisseria gonorrhoeae (Ceftriaxona 500 mg IM dosis única) y Chlamydia trachomatis (Doxiciclina 100 mg c/12h por 7 días), debido a la frecuencia extrema de coinfección oculta. El ciprofloxacino (C) no se utiliza por alta resistencia de gonococo en Chile (> 50%).

PREGUNTA 52 **Respuesta: C**

1.04.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH

La presencia de lesiones vesiculares agrupadas en racimo que evolucionan a úlceras superficiales dolorosas asociadas a adenopatías sensibles es el cuadro prototípico del primer episodio de Herpes Genital (generalmente por VHS-2). El tratamiento de elección para acortar el cuadro y reducir la eliminación viral es Aciclovir oral (400 mg cada 8 horas o 200 mg 5 veces al día por 7 a 10 días). El chancro sifilítico (B) es una úlcera única e indolora.

PREGUNTA 53 **Respuesta: A**

1.04.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH

Las cocáceas G(-) intracelulares son gonococo. Se debe tratar con ceftriaxona IM (259 mg por una vez), pero, además, se debe cubrir Chlamydia con doxiciclina o azitromicina o doxiciclina.

PREGUNTA 54 **Respuesta: E**

1.04.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH

Pregunta pésima, puede ser cualquiera de las opciones, menos la B. Sin embargo, la causa más frecuente de uretritis no gonocócica es la Chlamydia trachomatis. Si bien le falta clínica para tener una uretritis (solo tiene disuria, sin secreción uretral), pareciera que es lo que se está preguntando, dadas las alternativas.

BLOQUE 4 ZOONOSIS, MEDICINA TROPICAL Y VECTORES · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 55 **Respuesta: C** **Parasitosis intestinales** 1.04.1.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 25). Evalúa el manejo clínico de Parasitosis intestinales según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 56 **Respuesta: A**

1.04.2.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SCPH)

Hantavirus pulmonar en Chile es transmitido por ratón colilargo. Fase cardiopulmonar: edema pulmonar no cardiogénico + leucopenia + trombocitopenia. Es la causa más probable en zona rural del sur.

PREGUNTA 57 **Respuesta: A**

1.04.2.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SCPH)

El cuadro corresponde a un Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus. En esta patología, la permeabilidad capilar alveolar está severamente aumentada por fuga endotelial; la administración de bolos masivos de volumen (como los 30 mL/kg típicos de la sepsis bacteriana) precipita un edema pulmonar masivo irreversible y asfixia al paciente. La guía clínica del MINSAL contraindica la resucitación agresiva con fluidos y exige manejo hemodinámico restrictivo.

PREGUNTA 58 **Respuesta: B**

1.04.2.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SCPH)

El virus Andes se transmite casi exclusivamente por vía aérea mediante la inhalación de polvo y aerosoles suspendidos en el aire provenientes de la saliva, orina o heces desecadas del roedor silvestre Oligoryzomys longicaudatus (ratón de cola larga), frecuentemente al realizar limpieza de cabañas, galpones o bodegas que han permanecido cerradas durante largo tiempo.

PREGUNTA 59 **Respuesta: B**

1.04.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Enfermedad de Chagas: Aguda, Indeterminada y Crónica

En el recién nacido, los anticuerpos IgG atraviesan la placenta libremente, por lo que una serología IgG positiva solo refleja la infección materna y no confirma enfermedad en el niño. Por este motivo, la norma ministerial indica que el diagnóstico neonatal se realiza mediante métodos parasitológicos directos que buscan visualizar el parásito vivo en sangre (microhematocrito de sangre de cordón o capilar) o mediante PCR en centros de referencia.

PREGUNTA 60 **Respuesta: B**

1.04.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Enfermedad de Chagas: Aguda, Indeterminada y Crónica

La coexistencia de megacolon (fase digestiva) y alteraciones de conducción cardíaca típicas como el bloqueo completo de rama derecha (fase cardíaca) en un paciente procedente de una zona endémica histórica de Chile (IV Región) es la presentación característica de la Enfermedad de Chagas en fase crónica determinada. Se debe confirmar con serología IgG (ELISA e IFI).

PREGUNTA 61 **Respuesta: B**

1.04.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla

En los pacientes con sospecha de dengue, los antiinflamatorios no esteroidales (AINEs como Ketoprofeno, Ibuprofeno, Diclofenaco) y el ácido acetilsalicílico (Aspirina) están terminantemente contraindicados debido a su acción antiagregante plaquetaria y al riesgo de gatillar hemorragias digestivas graves y potenciar el colapso hemodinámico en caso de evolución a dengue grave. El analgésico y antipirético de elección es el Paracetamol.

PREGUNTA 62 **Respuesta: B**

1.04.1.008, 1.04.1.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla

En los pacientes con sospecha de dengue, los antiinflamatorios no esteroidales (AINEs como Ketoprofeno, Ibuprofeno, Diclofenaco) y el ácido acetilsalicílico (Aspirina) están terminantemente contraindicados debido a su acción antiagregante plaquetaria y al riesgo de gatillar hemorragias digestivas graves y potenciar el colapso hemodinámico en caso de evolución a dengue grave. El analgésico y antipirético de elección es el Paracetamol.

PREGUNTA 63 **Respuesta: A**

Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla

1.04.1.008, 1.04.1.018 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Plasmodium vivax y Plasmodium ovale tienen la capacidad biológica de generar formas intrahepáticas durmientes denominadas hipnozoítos, las cuales no son eliminadas por la cloroquina (que solo actúa sobre las formas intraeritrocitarias sanguíneas). Para lograr la cura radical y evitar recaídas que pueden presentarse meses después, es mandatario administrar Primaquina por 14 días, previa verificación de niveles normales de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD).

PREGUNTA 64 **Respuesta: C**

Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla

1.04.1.018 | Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Pregunta muy difícil, en especial porque es muy infrecuente la malaria por P. falciparum en América, incluyendo la Amazonía. Sin embargo, la presencia de anemia marcada hace que el diagnóstico sea malaria y no las demás opciones. La clínica es compatible también con el dengue. El virus Zika puede tener la misma clínica, pero suele ser menos intensa; a la fiebre amarilla le falta la ictericia; a la fiebre tifoidea le falta la diarrea.

PREGUNTA 65 **Respuesta: B**

Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis

1.04.1.013 | Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

Es un quiste hidatídico con el patrón ecográfico clásico (lesión quística con paredes y/o tabiques). El diagnóstico se confirmó ya con la Ecografía, pero la serología puede ayudar a confirmarlo y además sirve para el seguimiento postquirúrgico (en que deben disminuir los niveles de anticuerpos). Además, era la única opción relacionada con el diagnóstico.

PREGUNTA 66 **Respuesta: A**

Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis

1.04.1.013, 1.04.1.027 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

El antecedente del consumo de carne o embutidos de cerdo no fiscalizados sumado a la tríada de fiebre, edema bipalpebral y mialgias con hipereosinofilia marcada (> 30%) es patognomónico de Triquinosis (infección por Trichinella spiralis). La hidatidosis (B) no cursa con este cuadro muscular agudo ni con edema bipalpebral; el Chagas agudo (E) produce el signo de Romaña que es típicamente UNILATERAL.

PREGUNTA 67 **Respuesta: A**

Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis

1.04.1.013, 1.04.1.027 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

El hallazgo ecográfico del signo del camalote es característico de un quiste hidatídico hepático por Echinococcus granulosus. La complicación aguda más temida y de riesgo vital inminente es la rotura del quiste (sea espontánea por aumento de presión intracística o traumática tras un golpe menor), lo cual libera líquido hidatídico rico en antígenos altamente alergénicos hacia el peritoneo, desencadenando un shock anafiláctico fulminante y siembra peritoneal difusa de protoescólices.

PREGUNTA 68 **Respuesta: D**

Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis

1.04.1.027 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Tiene una triquinosis clásica: mialgias + eosinofilia + CK elevadas. Puede afectar el corazón y otros órganos. Se trata con analgésicos más albendazol o mebendazol. Si hay signos de gravedad (ej. miocardiGs de este caso), se agregan corticoides.

PREGUNTA 69 **Respuesta: A**

Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea

1.04.1.004 | Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 6). Evalúa el manejo clínico de Brucelosis según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 70 **Respuesta: B**

1.04.1.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea

Aunque el cuadro clínico es algo inespecífico, el hemograma con leucopenia, algo de desviación izquierda y aeosinofilia es el clásico “hemograma Vfico”.

PREGUNTA 71 **Respuesta: A**

1.04.1.017 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea

El antecedente de contacto con aguas estancadas y alcantarillados sumado al cuadro de fiebre, mialgias exquisitas en las pantorrillas y el signo patognomónico de sufusión conjuntival bilateral sin pus, que progresa a falla multiorgánica con ictericia severa y falla renal aguda (Síndrome de Weil), es diagnóstico de Leptospirosis grave por Leptospira interrogans. La hepatitis A (B) y la colangitis (C) no cursan con sufusión conjuntival ni dolor marcado en pantorrillas.

PREGUNTA 72 **Respuesta: A**

1.04.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Ántrax (Carbunco Cutáneo y Respiratorio)

La presentación clínica de una escara necrótica negruzca indolora con vesículas satélites y edema masivo en un trabajador expuesto a cueros o lanas animales es característica de carbunco cutáneo (Ántrax). El tratamiento antibiótico de elección recomendado internacionalmente por su alta efectividad y cobertura frente a cepas naturales y de bioseguridad es Ciprofloxacino oral (500 mg cada 12 h) o alternativamente Doxiciclina.

BLOQUE 5 INFECCIONES COMUNITARIAS, EXANTEMAS Y HUÉSPED INMUNOCOMPROMETIDO · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 73 **Respuesta: A** **Adenitis, adenoflegmón** 1.04.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Adenitis, adenoflegmón" (1.04.1.001), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 74 **Respuesta: E** **Influenza** 1.04.1.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta demasiado discutible, ya que los pacientes sin antecedentes de riesgo tienen la opción de usar oseltamivir, si así lo quieren, para disminuir el tiempo de influenza y asegurar que no será grave. La guía minsal solo da oseltamivir a pacientes con factores de riesgo o con influenza grave. Sin embargo el tratamiento sintomático es el de elección en la influenza. Se debe evitar la aspirina y el ibuprofeno, por el riesgo de síndrome de Reye. Además por la rinorrea y congestión, se puede sospechar otro virus, distinto a la influenza

---

PREGUNTA 75 **Respuesta: C** **Osteomielitis** 1.04.1.021 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tratamiento de Staphylococcus aureus Resistente a la Meticilina: Un antibiograma que muestra Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM), siendo resistente a los betalactámicos en general, incluyendo oxacilina y cefalosporinas. El tratamiento de elección para el SARM es la vancomicina.

PREGUNTA 76 **Respuesta: E**

1.04.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis

Parece una infección de una herida abrasiva. Como los bordes son parcialmente definidos, no queda claro si es una celulitis o una erisipela. Afortunadamente el cefa-

---

PREGUNTA 77 **Respuesta: B**

1.04.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis

La presencia de una placa eritematosa con bordes nítidos, claramente delimitados y sobreelevados es la descripción clásica de la erisipela, la cual es producida en más del 90% de los casos por Streptococcus pyogenes (estreptococo betahemolítico del grupo A). La celulitis por S. aureus o Gram negativos produce bordes planos y difusos.

PREGUNTA 78 **Respuesta: B**

1.04.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis

En la celulitis comunitaria no complicada, los microorganismos más frecuentes son Staphylococcus aureus meticilino-sensible y Streptococcus pyogenes. El tratamiento oral de primera línea de elección en Chile son las cefalosporinas de primera generación (Cefadroxilo 500 mg c/12h o Cefalexina 500 mg c/6h) o las penicilinas isoxazólicas (Flucloxacilina 500 mg c/8h), por su excelente perfil de eficacia y tolerancia.

PREGUNTA 79 **Respuesta: D**

1.04.1.025 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH

Tiene una mononucleosis clásica, con el síndrome mononucleósico (odinofagia, adenopaVas y fiebre), más los elementos clásicos: linfocitosis, hepatoesplenomegalia y hepaGGs (faltó el rash morbiliforme espontáneo o posterior al uso de aminopenicilinas).

PREGUNTA 80 **Respuesta: B**

1.04.1.025 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH

La tríada de faringitis exudativa, adenopatías cervicales posteriores y esplenomegalia asociada a la aparición de un exantema eritematoso difuso tras la ingesta de amoxicilina es patognomónica de Mononucleosis Infecciosa por Virus Epstein-Barr (VEB). La amoxicilina induce este rash en más del 90% de los pacientes infectados por VEB por alteración de la respuesta celular inmune.

PREGUNTA 81 **Respuesta: B**

1.04.1.025 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH

El Citomegalovirus (CMV) es la infección congénita más frecuente del complejo TORCH. Su hallazgo radiológico patognomónico son las calcificaciones en la zona subependimaria periventricular, y es la principal causa no genética de hipoacusia neurosensorial infantil. Toxoplasma (A) causa calcificaciones intraparenquimatosas difusas y coriorretinitis.

PREGUNTA 82 **Respuesta: C**

1.04.1.011 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki

Es una varicela en mayor de 13 años. La aspirina está contraindicada.

PREGUNTA 83 **Respuesta: B**

1.04.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki

El cuadro corresponde a Escarlatina, producida por cepas de Streptococcus pyogenes productoras de toxina eritrogénica. Para asegurar la erradicación bacteriana faríngea y prevenir complicaciones no supurativas tardías (especialmente la Fiebre Reumática aguda), la norma nacional e internacional exige administrar Amoxicilina oral durante 10 días completos (o alternativamente Penicilina Benzatina IM en dosis única). Pautas más cortas fracasan en prevenir la fiebre reumática.

PREGUNTA 84 **Respuesta: B**

1.04.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki

La complicación más temida de la Enfermedad de Kawasaki es la vasculitis coronaria, que sin tratamiento conduce a la formación de aneurismas coronarios en hasta el 25% de los pacientes, con riesgo subsecuente de infarto agudo de miocardio infantil y muerte súbita. La administración de IGEV (2 g/kg) en los primeros 10 días de evolución reduce esta incidencia a menos del 3-5%, siendo el pilar terapéutico cardioprotector indiscutido.

PREGUNTA 85 **Respuesta: A**

1.04.1.011, 1.04.2.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster

La neumonitis varicelosa es una complicación potencialmente mortal típica del adulto joven. El tratamiento de elección indiscutido es Aciclovir por vía ENDOVENOSA a dosis de 10 mg/kg cada 8 horas durante 7 a 10 días. La vía oral (B) es insuficiente debido a su baja biodisponibilidad (15-20%) y no logra concentraciones pulmonares terapéuticas suficientes para frenar la replicación viral en el pulmón. La inmunoglobulina (D) solo sirve para profilaxis post-exposición precoz, no para tratar la enfermedad establecida.

PREGUNTA 86 **Respuesta: A**

1.04.1.011, 1.04.2.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster

El cuadro corresponde a un Herpes Zóster Oftálmico que afecta la rama nasociliar del nervio oftálmico (V1 del trigémino), evidenciado por el signo de Hutchinson (vesículas en la punta de la nariz). Esta manifestación predice afectación corneal severa (queratitis dendrítica, uveítis anterior, glaucoma secundario y riesgo de pérdida visual irreversible). La conducta inmediata consiste en iniciar Aciclovir oral (800 mg 5 veces al día) o Valaciclovir y derivar de forma urgente al especialista en Oftalmología para examen con lámpara de hendidura.

PREGUNTA 87 **Respuesta: A**

1.04.2.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster

La neumonitis varicelosa es una complicación potencialmente mortal típica del adulto joven. El tratamiento de elección indiscutido es Aciclovir por vía ENDOVENOSA a dosis de 10 mg/kg cada 8 horas durante 7 a 10 días. La vía oral (B) es insuficiente debido a su baja biodisponibilidad (15-20%) y no logra concentraciones pulmonares terapéuticas suficientes para frenar la replicación viral en el pulmón. La inmunoglobulina (D) solo sirve para profilaxis post-exposición precoz, no para tratar la enfermedad establecida.

PREGUNTA 88 **Respuesta: A**

1.04.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco

El paciente cursa con una neutropenia febril de alto riesgo (RAN < 500 en contexto de leucemia mieloide aguda). La recomendación Surviving Sepsis y las guías internacionales de neutropenia febril exigen el inicio inmediato de antibioterapia antipseudomónica endovenosa de amplio espectro (tiempo puerta-aguja < 60 minutos), siendo Cefepime 2 g c/8h EV (o Piperacilina-Tazobactam) el fármaco de elección. Ceftriaxona (B) no tiene cobertura contra Pseudomonas aeruginosa, el germen más letal en este escenario.

PREGUNTA 89 **Respuesta: A**

1.04.1.020, 1.04.1.024 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco

El paciente cursa con una neutropenia febril de alto riesgo (RAN < 500 en contexto de leucemia mieloide aguda). La recomendación Surviving Sepsis y las guías internacionales de neutropenia febril exigen el inicio inmediato de antibioterapia antipseudomónica endovenosa de amplio espectro (tiempo puerta-aguja < 60 minutos), siendo Cefepime 2 g c/8h EV (o Piperacilina-Tazobactam) el fármaco de elección. Ceftriaxona (B) no tiene cobertura contra Pseudomonas aeruginosa, el germen más letal en este escenario.

PREGUNTA 90 **Respuesta: A**

1.04.1.024 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco

El paciente cursa con una neutropenia febril de alto riesgo (RAN < 500 en contexto de leucemia mieloide aguda). La recomendación Surviving Sepsis y las guías internacionales de neutropenia febril exigen el inicio inmediato de antibioterapia antipseudomónica endovenosa de amplio espectro (tiempo puerta-aguja < 60 minutos), siendo Cefepime 2 g c/8h EV (o Piperacilina-Tazobactam) el fármaco de elección. Ceftriaxona (B) no tiene cobertura contra Pseudomonas aeruginosa, el germen más letal en este escenario.